BR survival guide
step by step

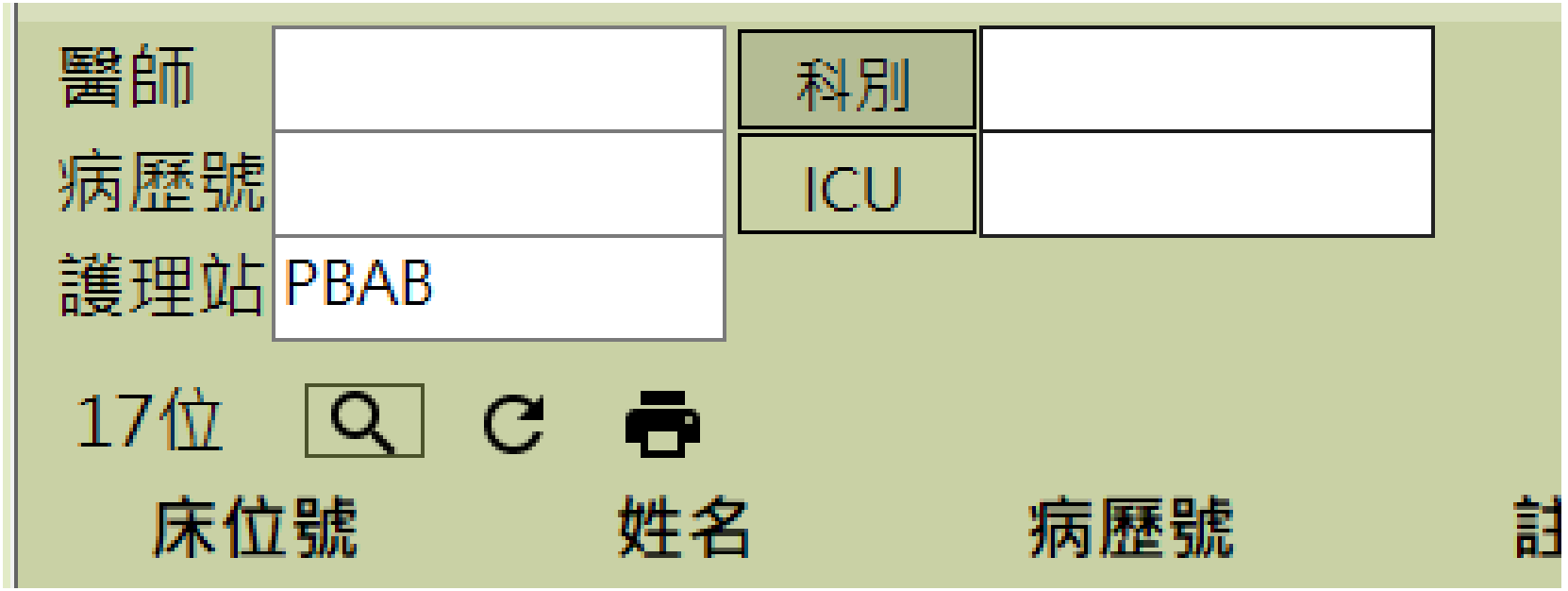
流程

1.做新生兒PE，有finding請告知護理師及上線(當天值6L的醫師)
2.住院通知單、住院同意書、一般同意書
3.醫囑
   - 打開產單
   - 嬰兒室出入院醫囑範本
   - 疫苗: HBV, HBIG
   - 新生兒篩檢額外項目
   - 新生兒自費檢查
   - 其餘特殊情況
4.完成入院病歷

Step 0. Newborn PE

- 請務必做新生兒PE
- 有異常或是不確定的請務必告知護理師及上線(當天值6L的醫師)

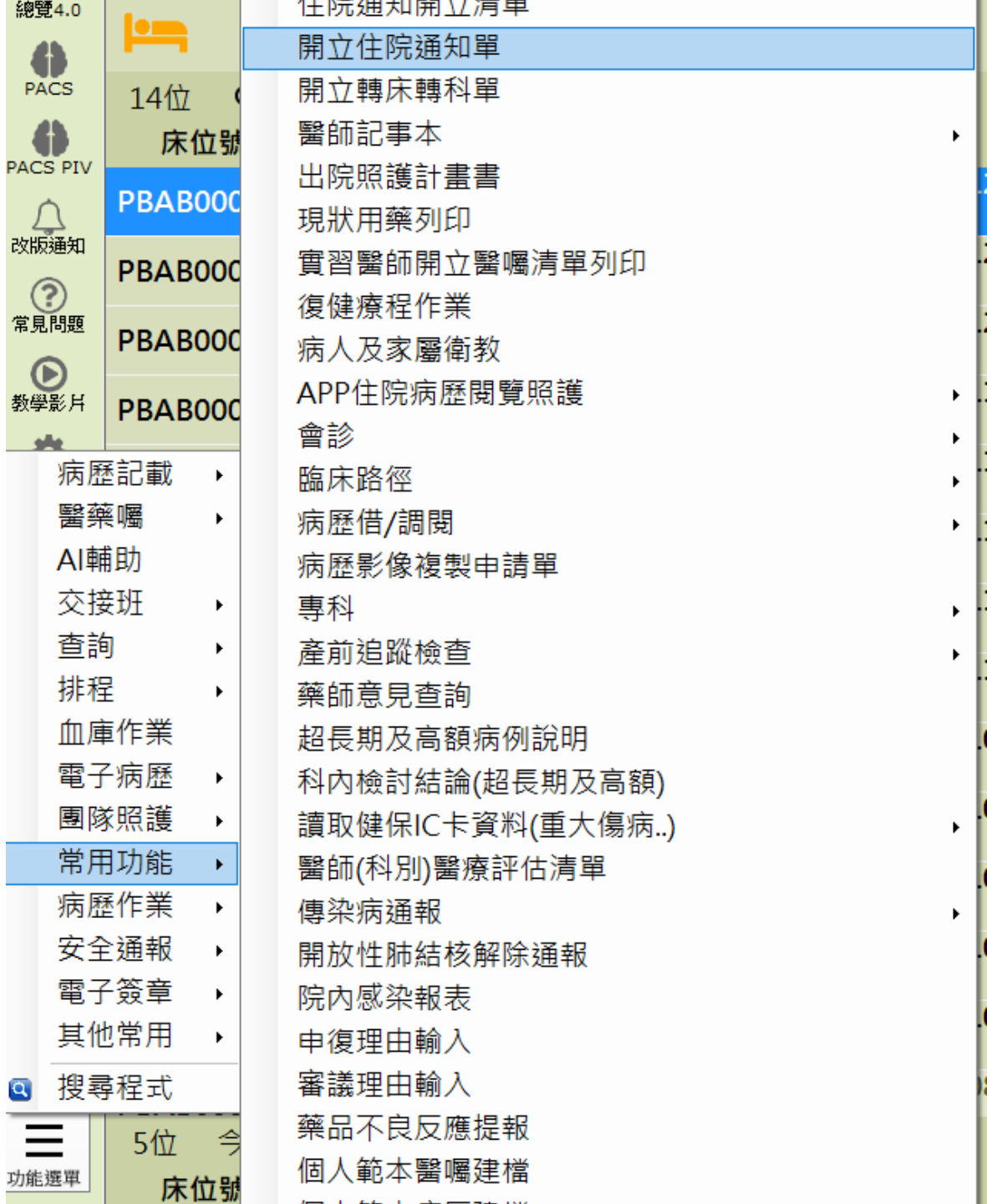
Step 1. 嬰兒室護理站代號 = PBAB



Step 2.1 住院通知單

- 左下角功能選單 → 常用功能 → 開立住院通知單

)



Step 2.1 住院通知單

- 左下角功能選單 → 常用功能 → 開立住院通知單
- 重複辦理住院，是否要繼續辦理? → 選確定



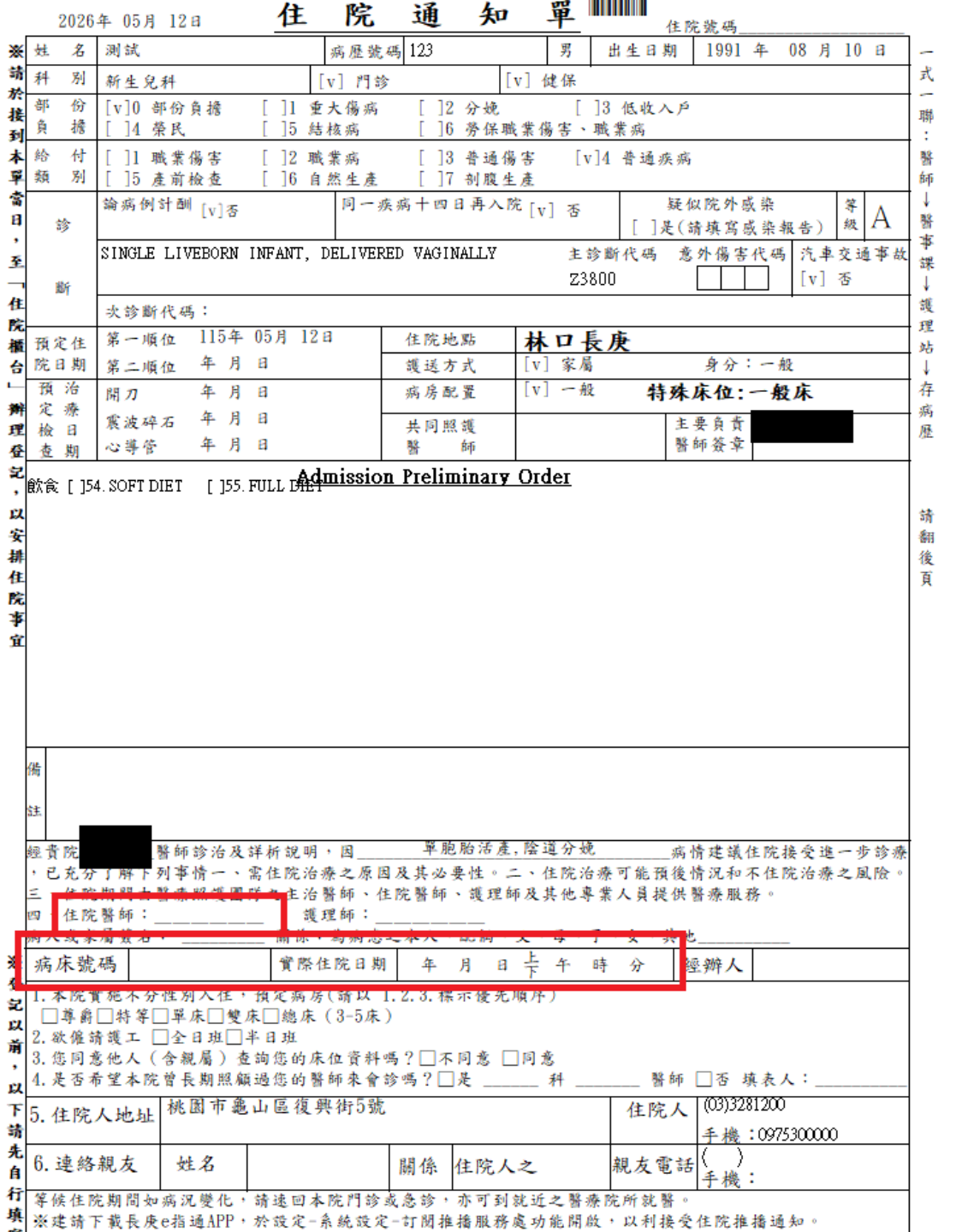
Step 2.1 住院通知單

- 左下角功能選單 → 常用功能 → 開立住院通知單
- 重複辦理住院，是否要繼續辦理? → 選確定
- 修改以下地方
  - 部分負擔：分娩
  - 給付類別：自然 or 剖腹產
  - 身分註記：一般
  - 醫師代號：填入主治四碼
  - 診斷代碼：Z3800, Z3801, Z3830, Z3831 擇一
  - 按存檔/列印



Step 2.1 住院通知單

- 左下角功能選單 → 常用功能 → 開立住院通知單
- 重複辦理住院，是否要繼續辦理? → 選確定
- 修改以下地方
  - 部分負擔：分娩
  - 給付類別：自然 or 剖腹產
  - 身分註記：一般
  - 醫師代號：填入主治四碼
  - 診斷代碼：Z3800, Z3801, Z3830, Z3831 擇一
  - 按存檔/列印
- 印出來後
  - 在住院醫師的地方蓋章
  - 填寫病床號碼、實際住院時間 (可在patient list看到)



2026年 05月 12日

住 院 通 知 單

住院號碼

※請於接到本單當日，至「住院櫃台」辦理登記，以安排住院事宜

姓 名	測試	病歷號碼	123	男	出生日期 1991 年 08 月 10 日
科 別	新生兒科	[v] 門診	[v] 健保		
部份負擔	[v]0 部份負擔 [ ]4 榮民	[ ]1 重大傷病 [ ]5 結核病	[ ]2 分娩 [ ]6 勞保職業傷害、職業病	[ ]3 低收入戶	
給付類別	[ ]1 職業傷害 [ ]5 產前檢查	[ ]2 職業病 [ ]6 自然生產	[ ]3 普通傷害 [ ]7 剖腹生產	[v]4 普通疾病	
診斷	論病例計酬 [v]否	同一疾病十四日再入院 [v] 否	疑似院外感染 [ ]是(請填寫感染報告)	等級 A	
	SINGLE LIVEBORN INFANT, DELIVERED VAGINALLY	主診斷代碼 Z3800	意外傷害代碼	汽車交通事故 [v] 否	
	次診斷代碼：				
預定住院日期	第一順位 115年 05月 12日	住院地點	林口長庚		
	第二順位 年 月 日	護送方式	[v] 家屬	身分：一般	
預定檢查日期	開刀 年 月 日	病房配置	[v] 一般	特殊床位:一般床	
	震波碎石 年 月 日	共同照護醫師		主要負責醫師簽章 [redacted]	
	心導管 年 月 日				

Admission Preliminary Order

飲食 [ ]54. SOFT DIET [ ]55. FULL DIET

備註

經貴院 [redacted] 醫師診治及詳析說明，因 單胞胎活產,陰道分娩 病情建議住院接受進一步診療，已充分了解下列事情一、需住院治療之原因及其必要性。二、住院治療可能預後情況和不住院治療之風險。三、住院期間由醫療照護團隊主治醫師、住院醫師、護理師及其他專業人員提供醫療服務。四、住院醫師：_____ 護理師：_____

病人或家屬簽名：_____ 關係：為病患之本人 配偶 父 母 子 女 其他_____

※住院登記以前，以下請先自行填寫

病床號碼		實際住院日期	年 月 日 上/下午 時 分	經辦人	

1. 本院實施不分性別入住，預定病房(請以 1.2.3.標示優先順序)
□尊爵□特等□單床□雙床□總床（3-5床）
2. 欲僱請護工 □全日班□半日班
3. 您同意他人（含親屬）查詢您的床位資料嗎？□不同意 □同意
4. 是否希望本院曾長期照顧過您的醫師來會診嗎？□是 _____ 科 _____ 醫師 □否 填表人：_____

5. 住院人地址	桃園市龜山區復興街5號			住院人	(03)3281200 手機：0975300000	
6. 連絡親友	姓名		關係	住院人之	親友電話	( ) 手機：

等候住院期間如病況變化，請速回本院門診或急診，亦可到就近之醫療院所就醫。
※建請下載長庚e指通APP，於設定-系統設定-訂閱推播服務處功能開啟，以利接受住院推播通知。

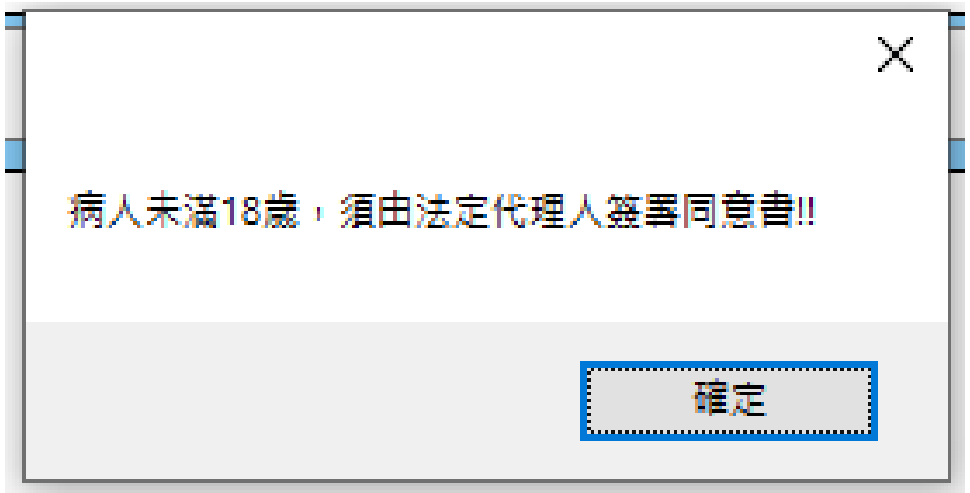
一式一聯：醫師↓醫事課↓護理站↓存病歷

請翻後頁

Step 2.2 開立同意書

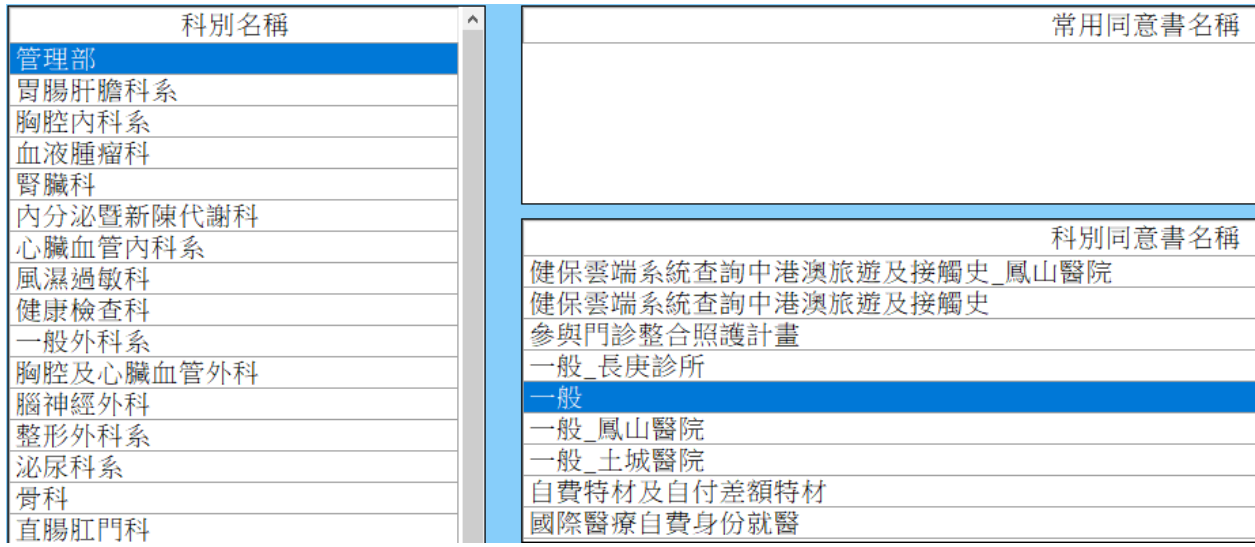
- 左下角功能選單 → 病歷記載 → 同意書 → 同意書開立
- 病人未滿18歲，須由法定代理人簽署同意書 → 確定

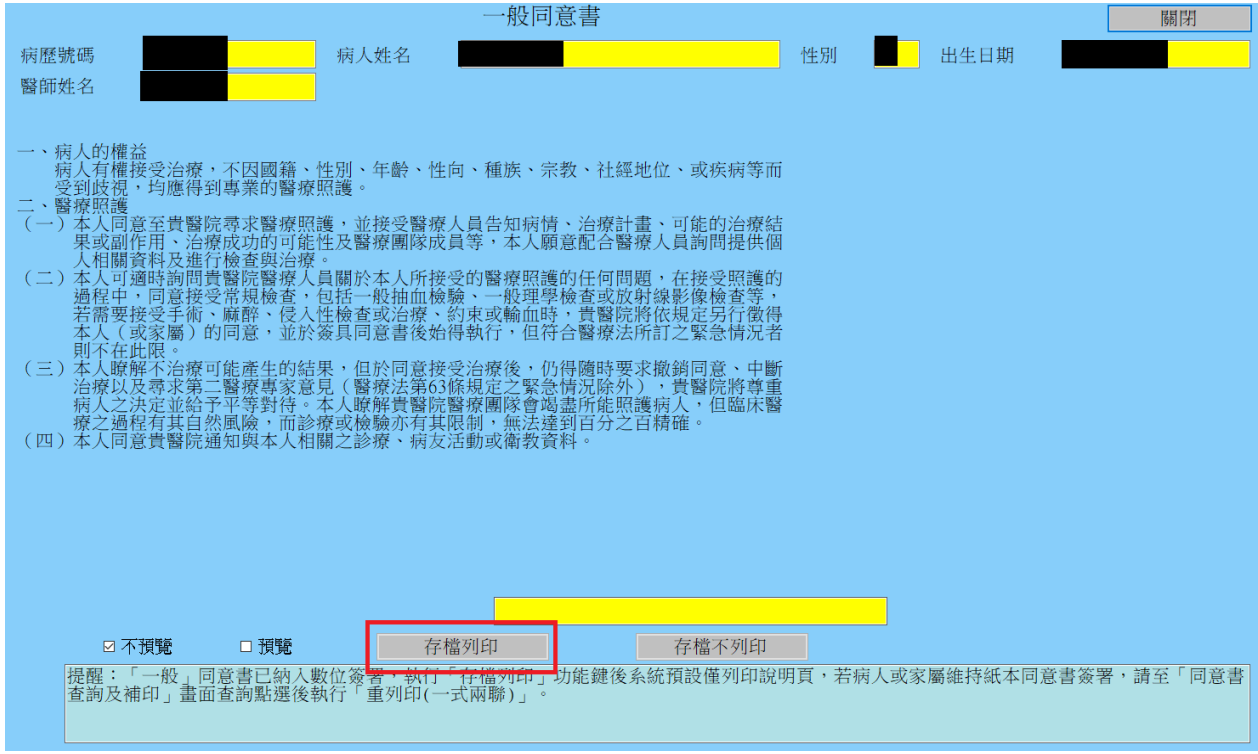




Step 2.2 開立同意書

- 左下角功能選單 → 病歷記載 → 同意書 → 同意書開立
- 病人未滿18歲，須由法定代理人簽署同意書 → 確定
- 點選一般同意書 → 存檔列印





Step 2.2 開立同意書

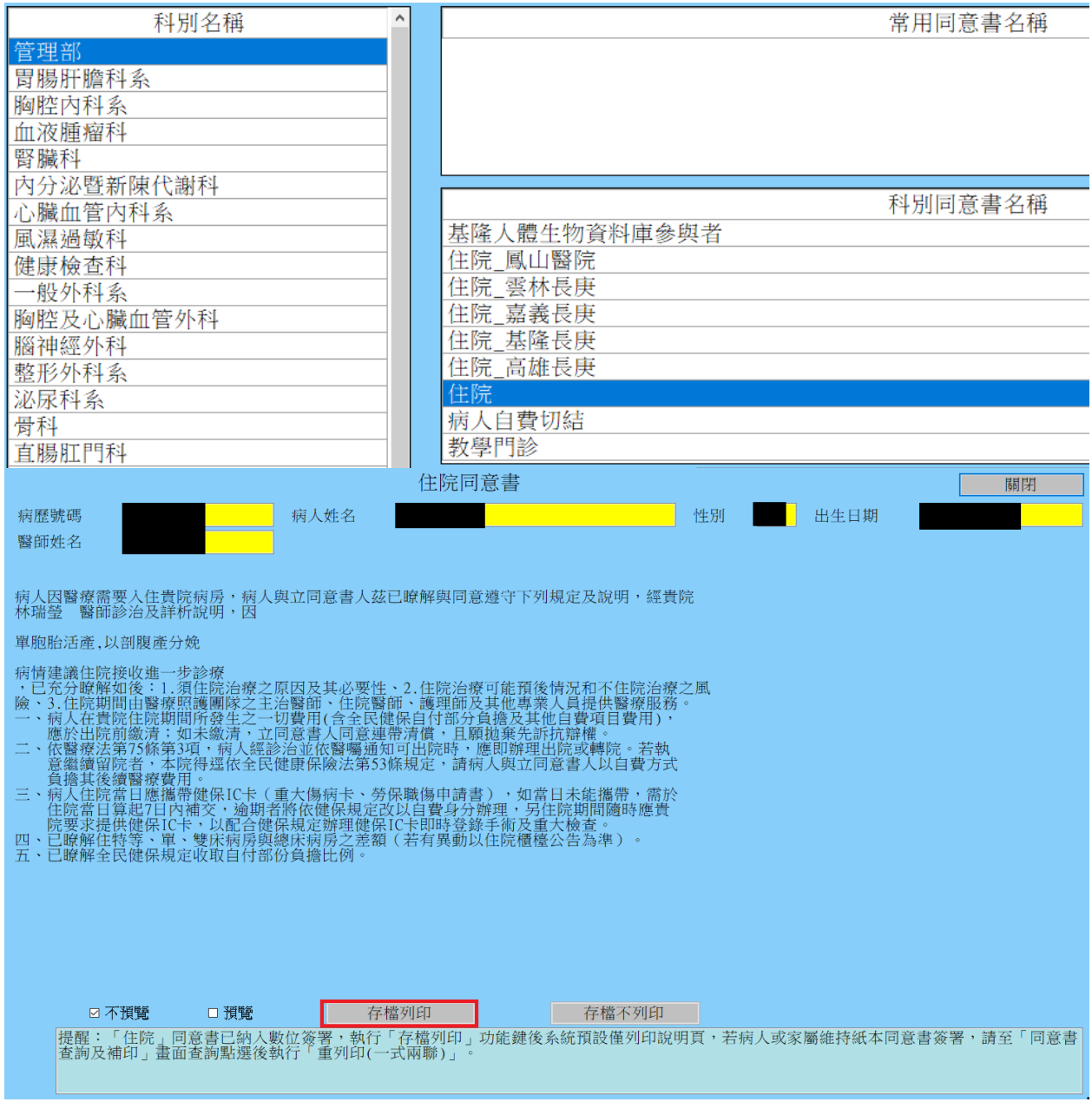
- 左下角功能選單 → 病歷記載 → 同意書 → 同意書開立
- 病人未滿18歲，須由法定代理人簽署同意書 → 確定
- 點選一般同意書 → 存檔列印
- 檢查開立住院通知單時是否有自動帶出住院同意書
  - 左下角功能選單 → 病歷記載 → 同意書 → 同意書查詢與補印





Step 2.2 開立同意書

- 左下角功能選單 → 病歷記載 → 同意書 → 同意書開立
- 病人未滿18歲，須由法定代理人簽署同意書 → 確定
- 點選一般同意書 → 存檔列印
- 檢查開立住院通知單時是否有自動帶出住院同意書
  - 左下角功能選單 → 病歷記載 → 同意書 → 同意書查詢與補印
  - 若病人未開立住院同意書，則點選住院同意書 → 存檔列印



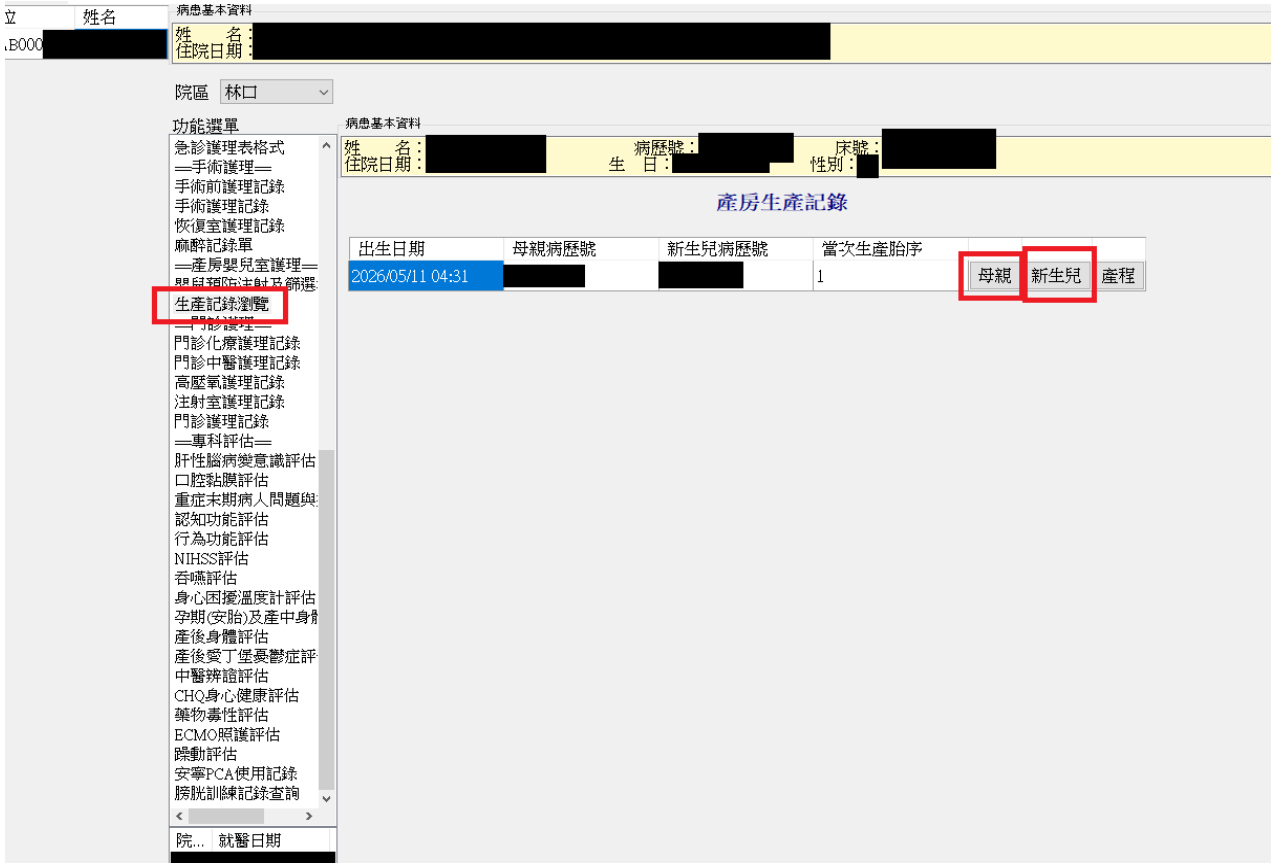
Step 3.1 醫囑 - 產單

- 打開產單
  - 左下角功能選單 → 電子病歷 → 護理紀錄 → 護理紀錄總覽



Step 3.1 醫囑 - 產單

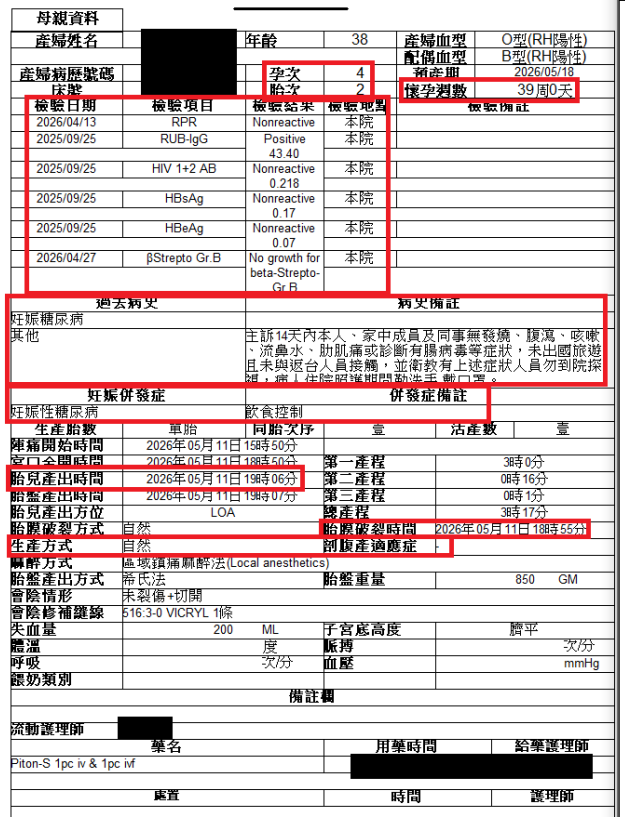
- 打開產單
  - 左下角功能選單 → 電子病歷 → 護理紀錄 → 護理紀錄總覽
  - 往下拉找到生產記錄瀏覽
  - 母親、新生兒都各點一下



Step 3.1 醫囑 - 產單

- 打開產單
  - 左下角功能選單 → 電子病歷 → 護理紀錄 → 護理紀錄總覽
  - 往下拉找到生產記錄瀏覽
  - 母親、新生兒都各點一下
  - 學會看產單
    - 檢驗項目(是否需要轉床?是否要給HBIG? 是否需要抽血?)
    - 過去病史、妊娠併發症(是否需要驗血糖?)
    - 胎膜破裂時間 - 胎兒產出時間 = 破水時間 (是否需要抽血?)
    - 身高、體重、頭圍(是否有SGA/LGA?是否需要驗血糖?)
    - 備註(是否有跟產房護理師不一致的PE findings?

*** 請參考附件嬰兒室protocol ***



母親資料

產婦姓名	[redacted]	年齡	38	產婦血型	O型(RH陽性)
				配偶血型	B型(RH陽性)
產婦病歷號碼		孕次	4	預產期	2026/05/18
床號		胎次	2	懷孕週數	39周0天

檢驗日期	檢驗項目	檢驗結果	檢驗地點	檢驗備註
2026/04/13	RPR	Nonreactive	本院	
2025/09/25	RUB-IgG	Positive 43.40	本院	
2025/09/25	HIV 1+2 AB	Nonreactive 0.218	本院	
2025/09/25	HBsAg	Nonreactive 0.17	本院	
2025/09/25	HBeAg	Nonreactive 0.07	本院	
2026/04/27	βStrepto Gr.B	No growth for beta-Strepto-Gr.B	本院	

過去病史	病史備註
妊娠糖尿病	
其他	主訴14天內本人、家中成員及同事無發燒、腹瀉、咳嗽、流鼻水、肌肌痛或診斷有腸病毒等症狀，未出國旅遊且未與返台人員接觸，並衛教有上述症狀人員勿到院探視，病人住院照護期間勤洗手 戴口罩。

妊娠併發症	併發症備註
妊娠性糖尿病	飲食控制

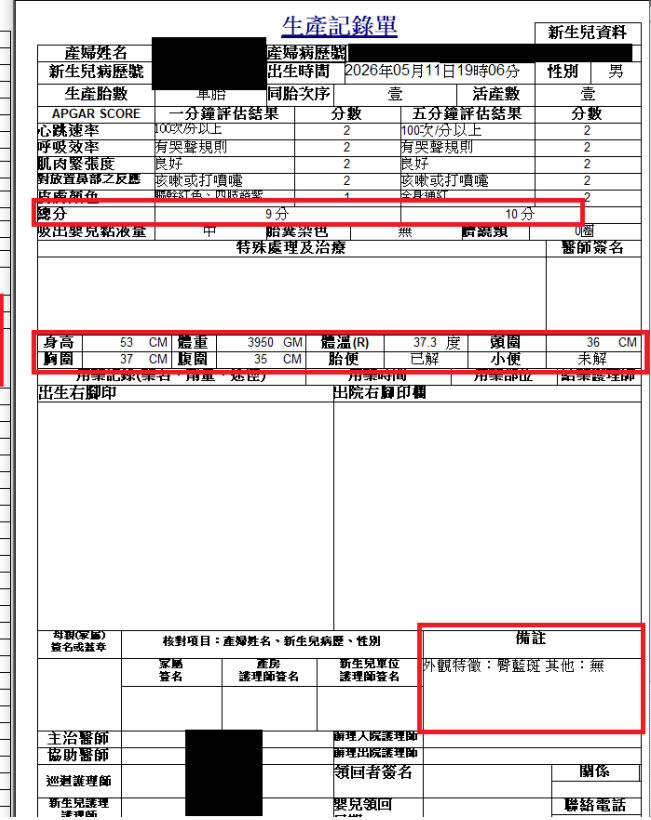
生產胎數	單胎	同胎次序	壹	活產數	壹
陣痛開始時間	2026年05月11日15時50分				
宮口全開時間	2026年05月11日18時50分	第一產程	3時0分		
胎兒產出時間	2026年05月11日19時06分	第二產程	0時16分		
胎盤產出時間	2026年05月11日19時07分	第三產程	0時1分		
胎兒產出方位	LOA	總產程	3時17分		
胎膜破裂方式	自然	胎膜破裂時間	2026年05月11日18時55分		
生產方式	自然	剖腹產適應症			
麻醉方式	區域鎮痛麻醉法(Local anesthetics)				
胎盤產出方式	希氏法	胎盤重量	850 GM		
會陰情形	未裂傷+切開				
會陰修補縫線	516.3-0 VICRYL 1條				
失血量	200 ML	子宮底高度	臍平		
體溫	度	脈搏	次/分		
呼吸	次/分	血壓	mmHg		
餵奶類別					

備註欄

流動護理師 [redacted]

藥名	用藥時間	給藥護理師
Piton-S 1pc iv & 1pc ivf	[redacted]	

處置	時間	護理師



生產記錄單

新生兒資料

產婦姓名	[redacted]	產婦病歷號	[redacted]		
新生兒病歷號		出生時間	2026年05月11日19時06分	性別	男
生產胎數	單胎	同胎次序	壹	活產數	壹

APGAR SCORE	一分鐘評估結果	分數	五分鐘評估結果	分數
心跳速率	100次/分以上	2	100次/分以上	2
呼吸效率	有哭聲規則	2	有哭聲規則	2
肌肉緊張度	良好	2	良好	2
對放置鼻部之反應	咳嗽或打噴嚏	2	咳嗽或打噴嚏	2
皮膚顏色	肢體紅色、四肢暗紫	1	全身通紅	2
總分	9 分		10 分	

羊水出嬰兒鼻腔液量	中	胎糞染色	無	臍帶類	嘴

特殊處理及治療 | 醫師簽名

身高	53 CM	體重	3950 GM	體溫(R)	37.3 度	頭圍	36 CM
胸圍	37 CM	腹圍	35 CM	胎便	已解	小便	未解

用藥記錄(藥名、劑量、途徑) | 用藥時間 | 用藥部位 | 給藥護理師

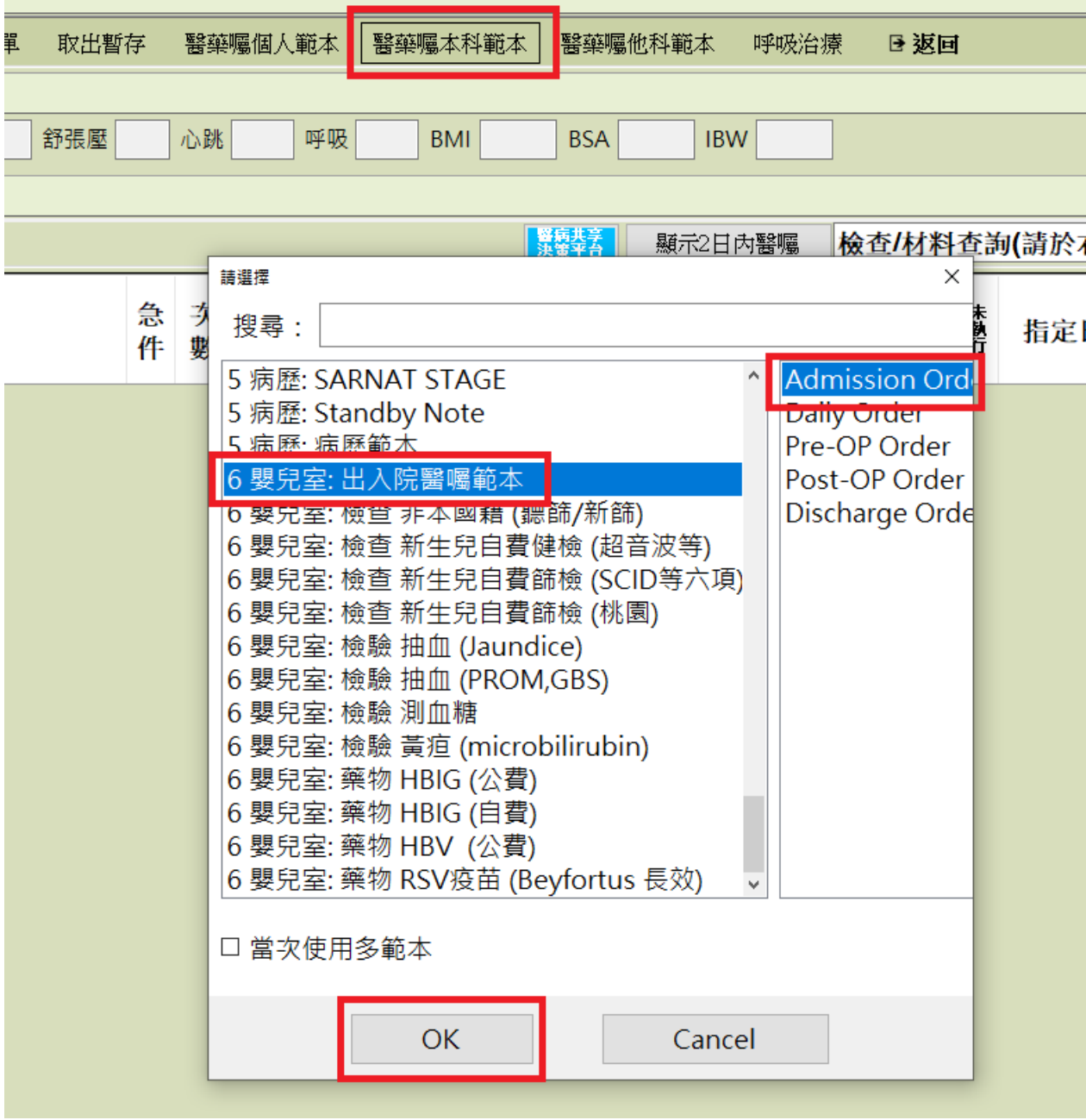
出生右腳印 | 出院右腳印欄

母親(家屬)簽名或蓋章	核對項目：產婦姓名、新生兒病歷、性別			備註
	家屬簽名	產房護理師簽名	新生兒單位護理師簽名	外觀特徵：臀藍斑 其他：無

主治醫師	[redacted]	新生兒護理師	
協助醫師		新生兒護理師	
巡迴護理師		領回者簽名	關係
新生兒護理師		嬰兒領回	聯絡電話

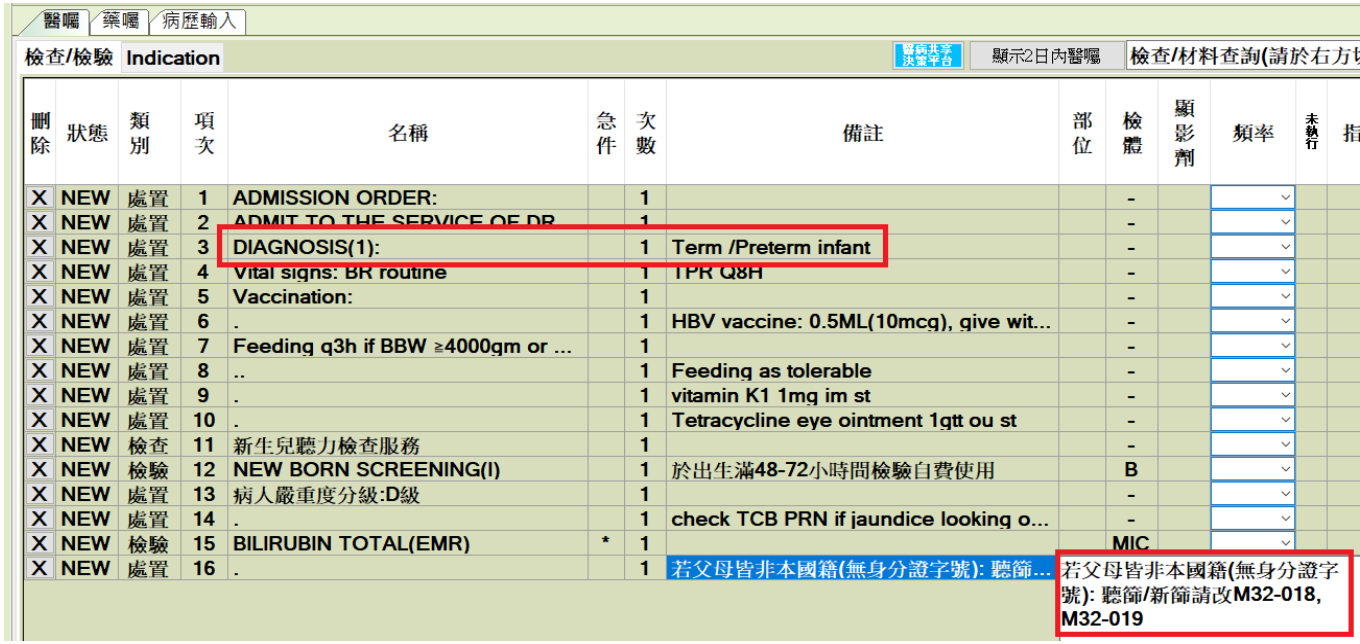
Step 3.2 醫囑 - 常規

- 醫藥囑本科範本 → **6 嬰兒室: 出入院醫囑範本** → Admission order → OK



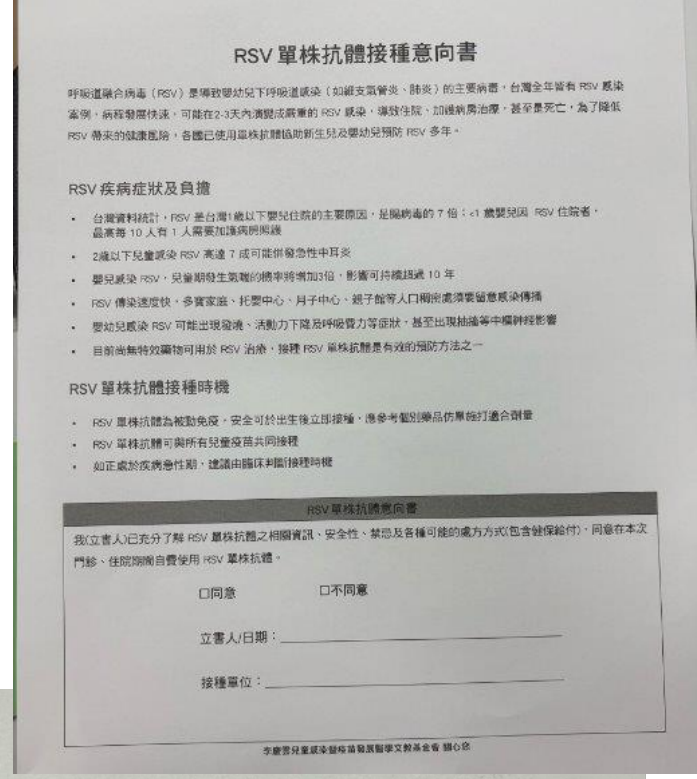
Step 3.2 醫囑 - 常規

- 醫藥囑本科範本 → **6 嬰兒室: 出入院醫囑範本** → Admission order → OK
  - 修改Diagnosis (Term or Preterm)
  - 若父母皆無身分證字號
    - 新生兒聽力檢查服務改M32-018
    - NEW BORN SCREENING(I)需改成M32-019
  - 其餘不須更動
  - 存檔列印
  - 是否要列印自費切結同意書? →是



Step 3.3 醫囑 - 疫苗

- 公費疫苗皆須**"單獨"存一筆** Order! (HBV、HBIG需分開存)
- **醫藥囑本科範本 → 6 嬰兒室: 藥物 選擇HBV/HBIG 公費 or 自費**
- RSV疫苗須以RSV疫苗同意書為準，有同意才開立



RSV 單株抗體接種意向書

呼吸道融合病毒（RSV）是導致嬰幼兒下呼吸道感染（如細支氣管炎、肺炎）的主要病毒，台灣全年皆有 RSV 感染案例，病程發展快速，可能在2-3天內演變成嚴重的 RSV 感染，導致住院，加護病房治療，甚至是死亡，為了降低 RSV 帶來的健康風險，各國已使用單株抗體協助新生兒及嬰幼兒預防 RSV 多年。

RSV 疾病症狀及負擔

- 台灣資料統計，RSV 是台灣1歲以下嬰兒住院的主要原因，是陽病毒的 7 倍；<1 歲嬰兒因 RSV 住院者，最高每 10 人有 1 人需要加護病房照護
- 2歲以下兒童感染 RSV 高達 7 成可能併發急性中耳炎
- 嬰兒感染 RSV，兒童期發生氣喘的機率將增加3倍，影響可持續超過 10 年
- RSV 傳染速度快，多寶家庭、托嬰中心、月子中心、親子館等人口稠密處須要留意感染傳播
- 嬰幼兒感染 RSV 可能出現發燒、活動力下降及呼吸費力等症狀，甚至出現抽搐等中樞神經影響
- 目前尚無特效藥物可用於 RSV 治療，接種 RSV 單株抗體是有效的預防方法之一

RSV 單株抗體接種時機

- RSV 單株抗體為被動免疫，安全可於出生後立即接種，應參考個別藥品仿單施打適合劑量
- RSV 單株抗體可與所有兒童疫苗共同接種
- 如正處於疾病急性期，建議由臨床判斷接種時機

RSV 單株抗體意向書

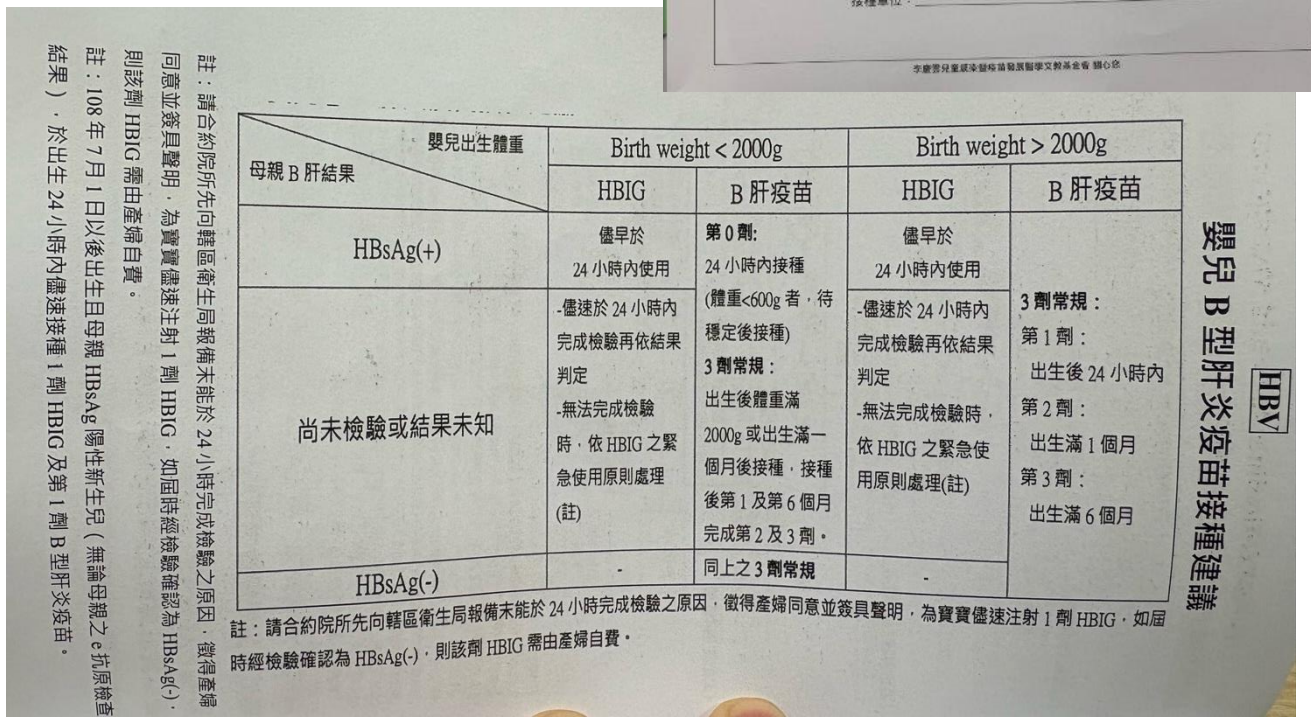
我(立書人)已充分了解 RSV 單株抗體之相關資訊、安全性、禁忌及各種可能的處方方式(包含健保給付)，同意在本次門診、住院期間自費使用 RSV 單株抗體。

□同意　□不同意

立書人/日期：_____

接種單位：_____

李麗雲兒童感染醫療基金會 關心您



嬰兒 B 型肝炎疫苗接種建議 HBV

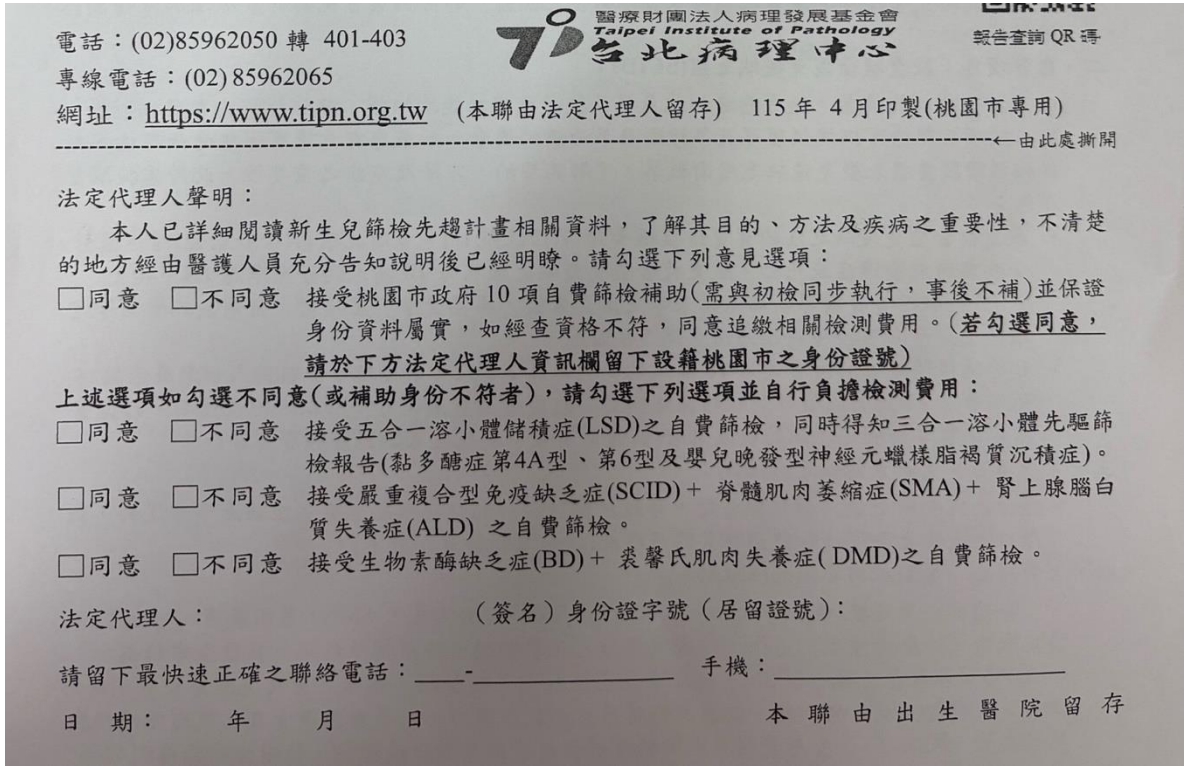
母親 B 肝結果 ＼ 嬰兒出生體重	Birth weight < 2000g		Birth weight > 2000g	
	HBIG	B 肝疫苗	HBIG	B 肝疫苗
HBsAg(+)	儘早於 24 小時內使用	**第 0 劑:** 24 小時內接種 (體重<600g 者，待穩定後接種) **3 劑常規：** 出生後體重滿 2000g 或出生滿一個月後接種，接種後第 1 及第 6 個月完成第 2 及 3 劑。	儘早於 24 小時內使用	**3 劑常規：** 第 1 劑：出生後 24 小時內 第 2 劑：出生滿 1 個月 第 3 劑：出生滿 6 個月
尚未檢驗或結果未知	-儘速於 24 小時內完成檢驗再依結果判定 -無法完成檢驗時，依 HBIG 之緊急使用原則處理(註)		-儘速於 24 小時內完成檢驗再依結果判定 -無法完成檢驗時，依 HBIG 之緊急使用原則處理(註)	
HBsAg(-)	-	同上之 **3 劑常規**	-	

註：請合約院所先向轄區衛生局報備未能於 24 小時完成檢驗之原因，徵得產婦同意並簽具聲明，為寶寶儘速注射 1 劑 HBIG，如屆時經檢驗確認為 HBsAg(-)，則該劑 HBIG 需由產婦自費。

註：108 年 7 月 1 日以後出生且母親 HBsAg 陽性新生兒（無論母親之 e 抗原檢查結果），於出生 24 小時內儘速接種 1 劑 HBIG 及第 1 劑 B 型肝炎疫苗。

Step 3.4 醫囑 - 新生兒篩檢額外項目

- 參考家屬同意書
  - 桃園補助者(有勾同意 "接受桃園市政府10項..."者)
    - DC 剛剛常規開立之NEW BORN SCREENING(I)
    - 點選醫藥囑本科範本 → 6 嬰兒室: 檢查 新生兒自費篩檢 (桃園) → 存檔列印 → 印自費同意書
  - 非桃園補助者
    - 點選醫藥囑本科範本 → 6 嬰兒室: 檢查 新生兒自費篩檢 (SCID等六項)
    - 只留下病人同意項目， 其餘刪除



電話：(02)85962050 轉 401-403
專線電話：(02) 85962065
網址：https://www.tipn.org.tw (本聯由法定代理人留存) 115 年 4 月印製(桃園市專用)

醫療財團法人病理發展基金會 Taipei Institute of Pathology 台北病理中心

報告查詢 QR 碼

←由此處撕開

法定代理人聲明：

本人已詳細閱讀新生兒篩檢先趨計畫相關資料，了解其目的、方法及疾病之重要性，不清楚的地方經由醫護人員充分告知說明後已經明瞭。請勾選下列意見選項：

□同意 □不同意 接受桃園市政府 10 項自費篩檢補助(需與初檢同步執行，事後不補)並保證身份資料屬實，如經查資格不符，同意追繳相關檢測費用。(若勾選同意，請於下方法定代理人資訊欄留下設籍桃園市之身份證號)

上述選項如勾選不同意(或補助身份不符者)，請勾選下列選項並自行負擔檢測費用：

□同意 □不同意 接受五合一溶小體儲積症(LSD)之自費篩檢，同時得知三合一溶小體先驅篩檢報告(黏多醣症第4A型、第6型及嬰兒晚發型神經元蠟樣脂褐質沉積症)。

□同意 □不同意 接受嚴重複合型免疫缺乏症(SCID)＋脊髓肌肉萎縮症(SMA)＋腎上腺腦白質失養症(ALD) 之自費篩檢。

□同意 □不同意 接受生物素酶缺乏症(BD)＋裘馨氏肌肉失養症(DMD)之自費篩檢。

法定代理人： (簽名) 身份證字號 (居留證號)：

請留下最快速正確之聯絡電話：____-_____ 手機：_____

日 期： 年 月 日

本聯由出生醫院留存

Step 3.4 醫囑 - 新生兒自費檢查

- 選醫藥囑本科範本 → 6 嬰兒室: 檢查 新生兒自費健檢 (超音波等)
  - 只留下病人同意項目，其餘刪除
  - 切記!! 以下請記得手動修改成自費!!
    - 腹部超音波
    - 腦部超音波
    - 腎臟超音波
    - 脊髓超音波



自費檢查同意書(請於寶寶出生4小時內繳回)

嬰兒姓名/病歷號/床號/出生日期：_____ (此欄護理師填寫)

1.腹部超音波	M32-061	NT$ 800	□同意	□不同意
2.肝脾腎上腺超音波	M32-063	NTS 882	□同意	□不同意
3.腰骨部骨髓超音波	M32-102	NTS 1000	□同意	□不同意
4.髖關節超音波	S45-235-Z	NTS 2000	□同意	□不同意
若您有勾選心、腎、IGE任一項檢查， 視您同意院方安排您的寶寶滿月後過林口長庚檢查或看報告				
5.心臟超音波	M22-051-ZT	NTS 2000	□同意	□不同意
6.腎臟輸尿超音波	M32-064	NTS 1000	□同意	□不同意
7.過敏性 IGE 非超音波 (滿月看報告前過敏原，額外抽血)	M32-224	NTS 600	□同意	□不同意
8.聽損基因檢測 (與新生兒篩檢一起抽血，滿月看報告)	E72-664	NTS 2500	□同意	□不同意

立同意書人(簽名)：　　與寶寶關係：　　日期：　年　月　日

聯絡電話：

您已詳閱以上內容且「產婦知情」勾選之檢查項目。

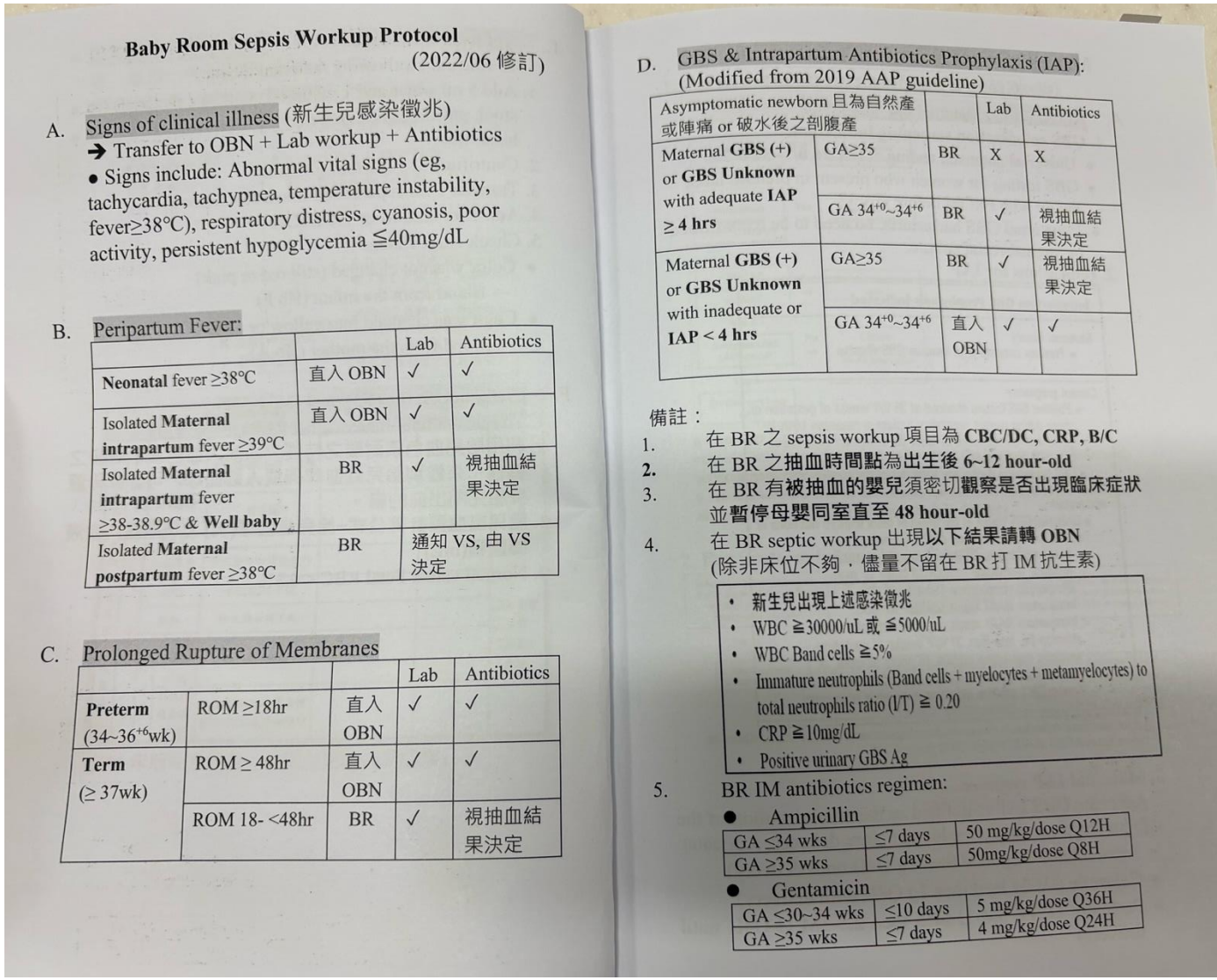
Step 3.4 醫囑 - 其餘特殊情況

- 血糖
  - 誰有低血糖風險，需監測血糖?
    - BBW < 2500g OR ≧4000g
    - Infant of DM mother or maternal GDM
  - 測血糖order
    - 選醫藥囑本科範本 → 6 嬰兒室: 檢驗 測血糖 → 存檔列印

<< CHECK F/S ORDER>>
Check fasting F/S stat ,then recheck Q30'x1,Q1hx1,Q2hx1,Q4hx1
If any F/S≦40mg/dL, feed milk or D10W 10-20ml,and recheck F/S 30min later
Keep feeding Q3h
Notify Dr. if F/S≦40mg/dL twice or ANY F/S<25mg/dL

Step 3.4 醫囑 - 其餘特殊情況

- 感染
  - 誰有感染風險，需抽血檢驗? 誰需抗生素? 劑量? 請參考Protocol
  - 選醫藥囑本科範本 → 6 嬰兒室: 檢驗 抽血 (PROM, GBS, Fever) → 根據病人狀況選擇適當之抗生素與劑量 → 存檔



Baby Room Sepsis Workup Protocol
(2022/06 修訂)

A. Signs of clinical illness (新生兒感染徵兆)
➔ Transfer to OBN + Lab workup + Antibiotics
• Signs include: Abnormal vital signs (eg, tachycardia, tachypnea, temperature instability, fever≥38°C), respiratory distress, cyanosis, poor activity, persistent hypoglycemia ≦40mg/dL

B. Peripartum Fever:

		Lab	Antibiotics
Neonatal fever ≥38°C	直入 OBN	✓	✓
Isolated **Maternal intrapartum** fever ≥39°C	直入 OBN	✓	✓
Isolated **Maternal intrapartum** fever ≥38-38.9°C & **Well baby**	BR	✓	視抽血結果決定
Isolated **Maternal postpartum** fever ≥38°C	BR	通知 VS, 由 VS 決定	

C. Prolonged Rupture of Membranes

			Lab	Antibiotics
Preterm (34~36^{+6}wk)	ROM ≥18hr	直入 OBN	✓	✓
Term (≥ 37wk)	ROM ≥ 48hr	直入 OBN	✓	✓
	ROM 18- <48hr	BR	✓	視抽血結果決定

D. GBS & Intrapartum Antibiotics Prophylaxis (IAP):
(Modified from 2019 AAP guideline)

Asymptomatic newborn 且為自然產或陣痛 or 破水後之剖腹產		Lab	Antibiotics
Maternal **GBS (+)** or **GBS Unknown** with adequate **IAP ≥ 4 hrs**	GA≥35	BR	X	X
	GA 34^{+0}~34^{+6}	BR	✓	視抽血結果決定
Maternal **GBS (+)** or **GBS Unknown** with inadequate or **IAP < 4 hrs**	GA≥35	BR	✓	視抽血結果決定
	GA 34^{+0}~34^{+6}	直入 OBN	✓	✓

備註：
1. 在 BR 之 sepsis workup 項目為 **CBC/DC, CRP, B/C**
2. 在 BR 之**抽血時間點為出生後 6~12 hour-old**
3. 在 BR 有**被抽血的嬰兒**須密切**觀察是否出現臨床症狀並暫停母嬰同室直至 48 hour-old**
4. 在 BR septic workup 出現**以下結果請轉 OBN**
(除非床位不夠，儘量不留在 BR 打 IM 抗生素)
   - 新生兒出現上述感染徵兆
   - WBC ≧30000/uL 或 ≦5000/uL
   - WBC Band cells ≧5%
   - Immature neutrophils (Band cells + myelocytes + metamyelocytes) to total neutrophils ratio (I/T) ≧ 0.20
   - CRP ≧10mg/dL
   - Positive urinary GBS Ag
5. BR IM antibiotics regimen:
   - Ampicillin

GA ≤34 wks	≤7 days	50 mg/kg/dose Q12H
GA ≥35 wks	≤7 days	50mg/kg/dose Q8H

   - Gentamicin

GA ≤30~34 wks	≤10 days	5 mg/kg/dose Q36H
GA ≥35 wks	≤7 days	4 mg/kg/dose Q24H

Step 3.4 醫囑 - 其餘特殊情況

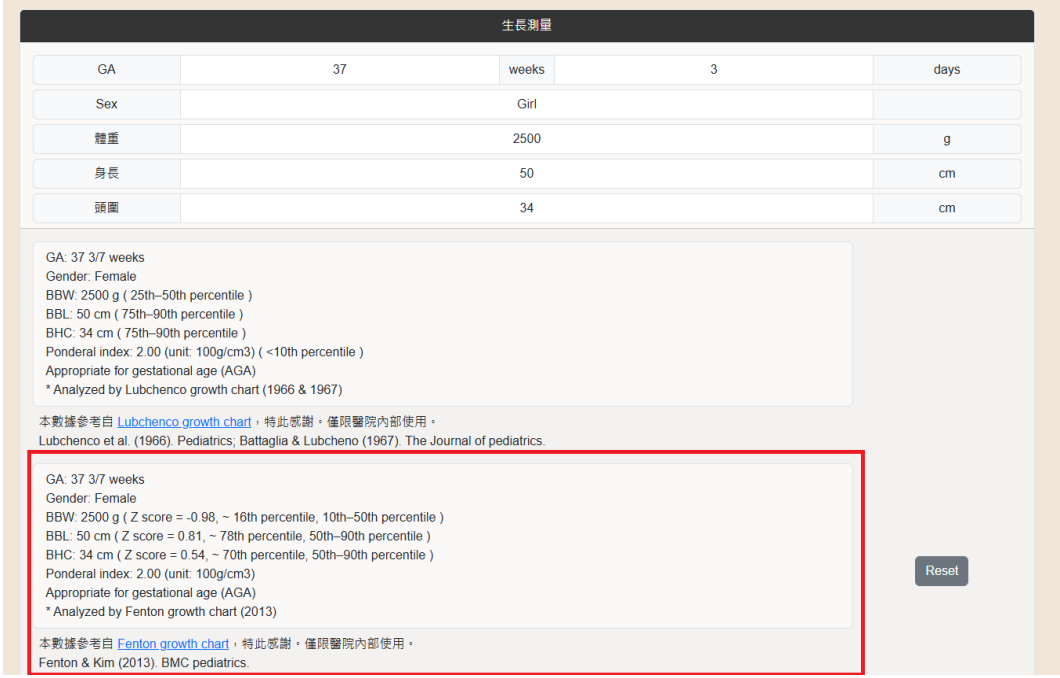
- 黃疸
  - 誰需要進一步抽血檢查?
    - Microbilirubin > 5 at first day
    - Microbilirubin > 15 at any age
    - Prolonged jaundice after phototherapy for 3 days
  - 抽血單開立
    - 選醫藥囑本科範本 → 6 嬰兒室: 檢驗 抽血 (Jaundice) → 存檔列印
  - 誰需要照光治療?
    - 參考曲線圖 (附件)
  - 照幾台?
    - 照光1台 = JOD301 = On phototherapy
    - 照光2台 = D919-030 = Intensive phototherapy (加強照光)

Step 3.4 醫囑 - 其餘特殊情況

- JOD406 CONTACT ISOLATION
  - Indication:

Step 4 完成入院病歷

- 選科範本 → 6 嬰兒室: 出入院醫囑範本
- 皆有設範本，請根據病人狀況選擇修改
- Impression請加入生產方式、GA、BBW、Apgar score如下
  - Healthy term newborn, born via cesarean section, with gestational age _ weeks, BBW _ gm, Apgar Score 9 to 10
- General Data處須輸入要輸入新生兒評估
  - https://mpq197.github.io/#tool=growth
  - **選擇Fenton的參考指標，點一下即可複製**

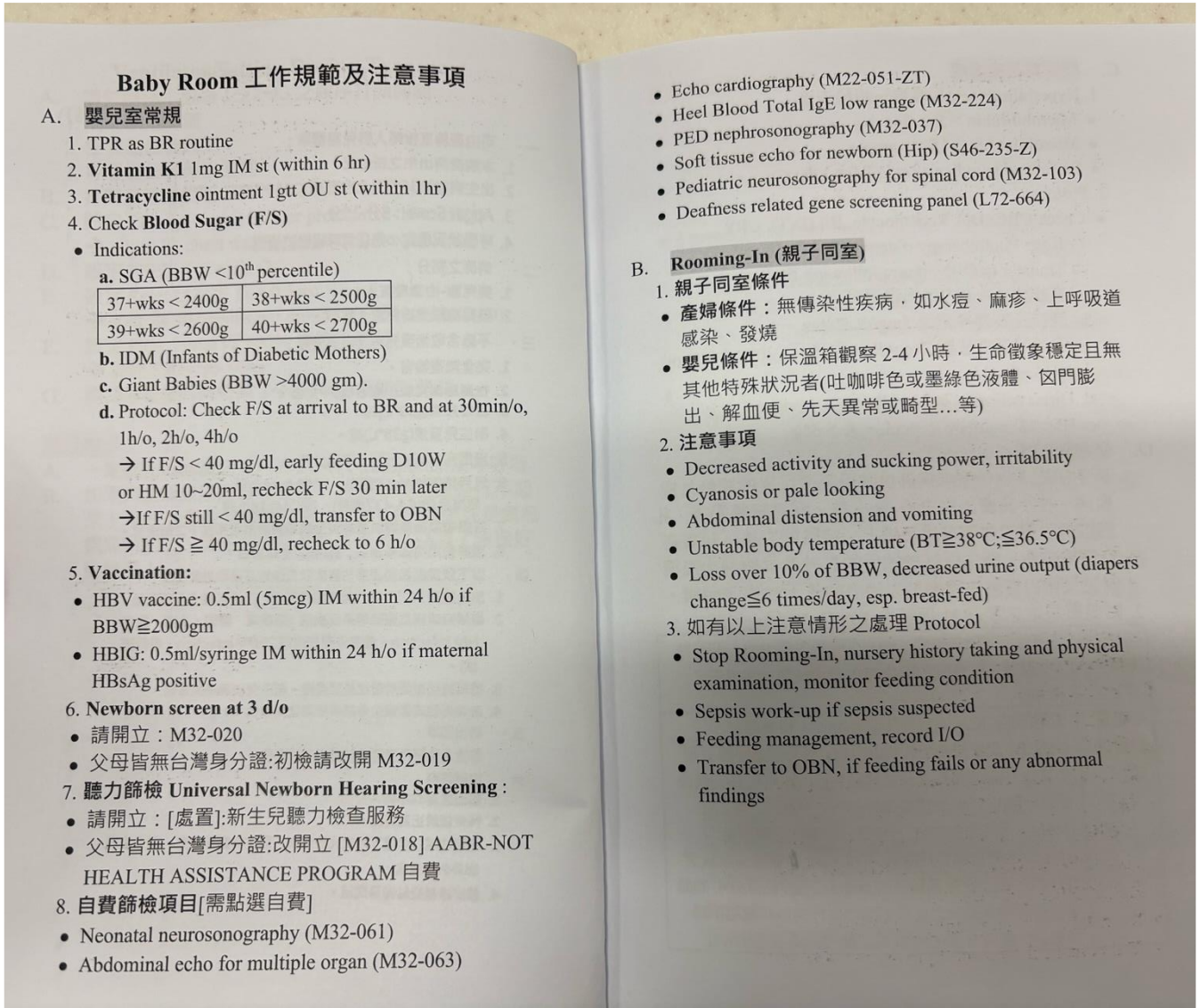


入院日期:2026/05/12

一般資料:(General Data)

學歷:無
職業:無
婚姻:未婚
種族:台灣
身心(精神心理):睡眠品質可
社會經濟:經濟中等
宗教:未提供
居住地:未提供
(1)身體機能:可自由活動(嬰幼兒)
(2)營養:well development
(3)護理:無特殊護理處置
(4)居住狀況:非獨居
(5)主要照顧者:病人之父，母
(6)職業病史:
(7)資料提供者:病人之父
GA: 38 6/7 weeks
Gender: Male
BBW: 3320 g (75th－90th percentile)
BBL: 48 cm (25th－50th percentile)
BHC: 36 cm (>90th percentile)
Ponderal index: 3.00 (unit: 100g/cm3) (75th－90th percentile)
Appropriate for gestational age (AGA)

附件 - 嬰兒室protocol - Routine



Baby Room 工作規範及注意事項

A. **嬰兒室常規**

1. TPR as BR routine
2. **Vitamin K1** 1mg IM st (within 6 hr)
3. **Tetracycline** ointment 1gtt OU st (within 1hr)
4. Check **Blood Sugar (F/S)**
   - Indications:
     a. SGA (BBW <10th percentile)

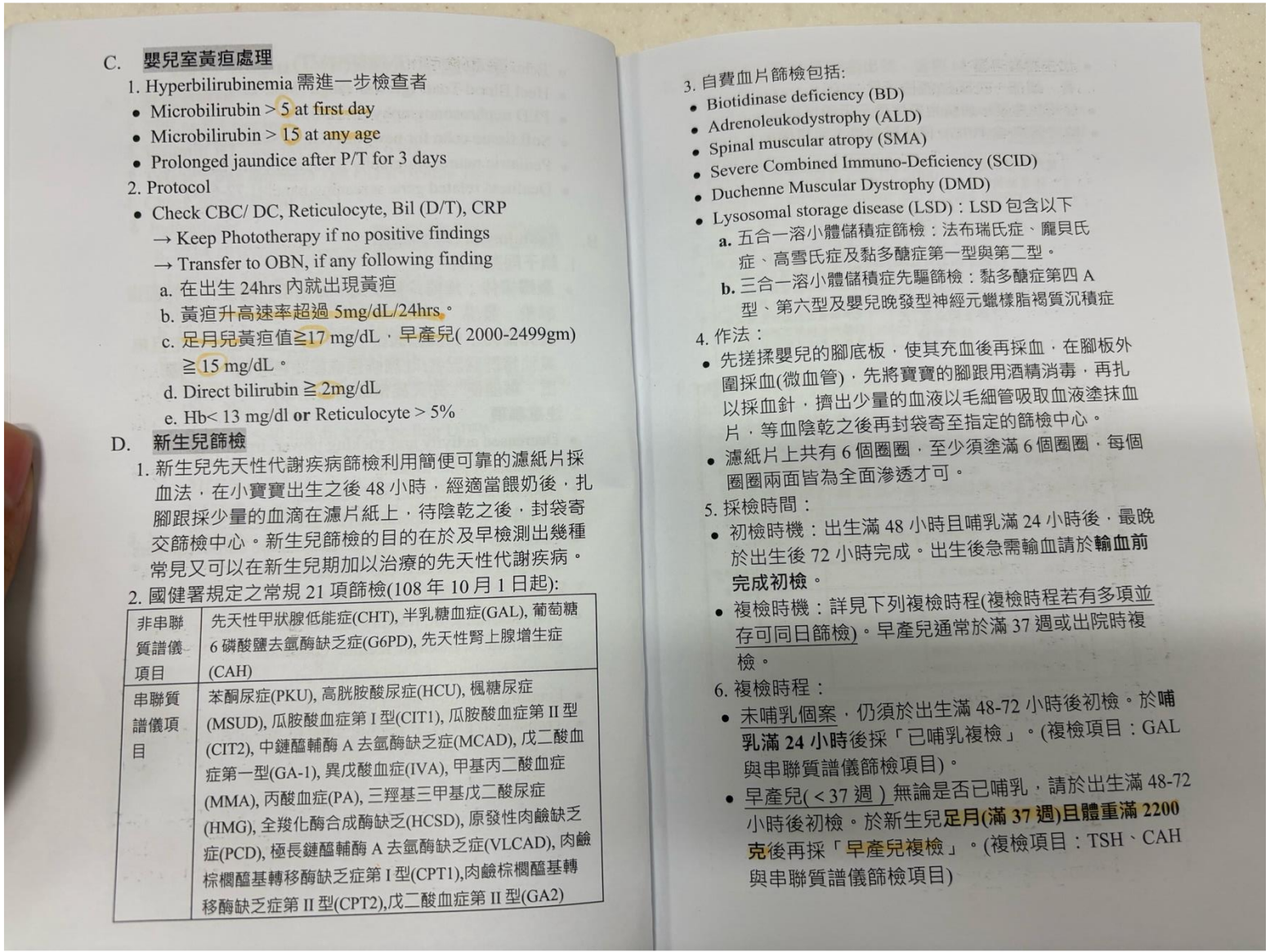
37+wks < 2400g	38+wks < 2500g
39+wks < 2600g	40+wks < 2700g

     b. IDM (Infants of Diabetic Mothers)
     c. Giant Babies (BBW >4000 gm).
     d. Protocol: Check F/S at arrival to BR and at 30min/o, 1h/o, 2h/o, 4h/o
     → If F/S < 40 mg/dl, early feeding D10W or HM 10~20ml, recheck F/S 30 min later
     →If F/S still < 40 mg/dl, transfer to OBN
     → If F/S ≧ 40 mg/dl, recheck to 6 h/o
5. **Vaccination:**
   - HBV vaccine: 0.5ml (5mcg) IM within 24 h/o if BBW≧2000gm
   - HBIG: 0.5ml/syringe IM within 24 h/o if maternal HBsAg positive
6. **Newborn screen at 3 d/o**
   - 請開立：M32-020
   - 父母皆無台灣身分證:初檢請改開 M32-019
7. **聽力篩檢 Universal Newborn Hearing Screening** :
   - 請開立：[處置]:新生兒聽力檢查服務
   - 父母皆無台灣身分證:改開立 [M32-018] AABR-NOT HEALTH ASSISTANCE PROGRAM 自費
8. **自費篩檢項目**[需點選自費]
   - Neonatal neurosonography (M32-061)
   - Abdominal echo for multiple organ (M32-063)
   - Echo cardiography (M22-051-ZT)
   - Heel Blood Total IgE low range (M32-224)
   - PED nephrosonography (M32-037)
   - Soft tissue echo for newborn (Hip) (S46-235-Z)
   - Pediatric neurosonography for spinal cord (M32-103)
   - Deafness related gene screening panel (L72-664)

B. **Rooming-In (親子同室)**

1. **親子同室條件**
   - **產婦條件**：無傳染性疾病，如水痘、麻疹、上呼吸道感染、發燒
   - **嬰兒條件**：保溫箱觀察 2-4 小時，生命徵象穩定且無其他特殊狀況者(吐咖啡色或墨綠色液體、囟門膨出、解血便、先天異常或畸型…等)
2. **注意事項**
   - Decreased activity and sucking power, irritability
   - Cyanosis or pale looking
   - Abdominal distension and vomiting
   - Unstable body temperature (BT≧38°C;≦36.5°C)
   - Loss over 10% of BBW, decreased urine output (diapers change≦6 times/day, esp. breast-fed)
3. 如有以上注意情形之處理 Protocol
   - Stop Rooming-In, nursery history taking and physical examination, monitor feeding condition
   - Sepsis work-up if sepsis suspected
   - Feeding management, record I/O
   - Transfer to OBN, if feeding fails or any abnormal findings

附件 - 嬰兒室protocol - Routine



C. **嬰兒室黃疸處理**

1. Hyperbilirubinemia 需進一步檢查者
   - Microbilirubin > 5 at first day
   - Microbilirubin > 15 at any age
   - Prolonged jaundice after P/T for 3 days
2. Protocol
   - Check CBC/ DC, Reticulocyte, Bil (D/T), CRP
     → Keep Phototherapy if no positive findings
     → Transfer to OBN, if any following finding
     a. 在出生 24hrs 內就出現黃疸
     b. 黃疸升高速率超過 5mg/dL/24hrs。
     c. 足月兒黃疸值≧17 mg/dL，早產兒(2000-2499gm) ≧15 mg/dL。
     d. Direct bilirubin ≧ 2mg/dL
     e. Hb< 13 mg/dl **or** Reticulocyte > 5%

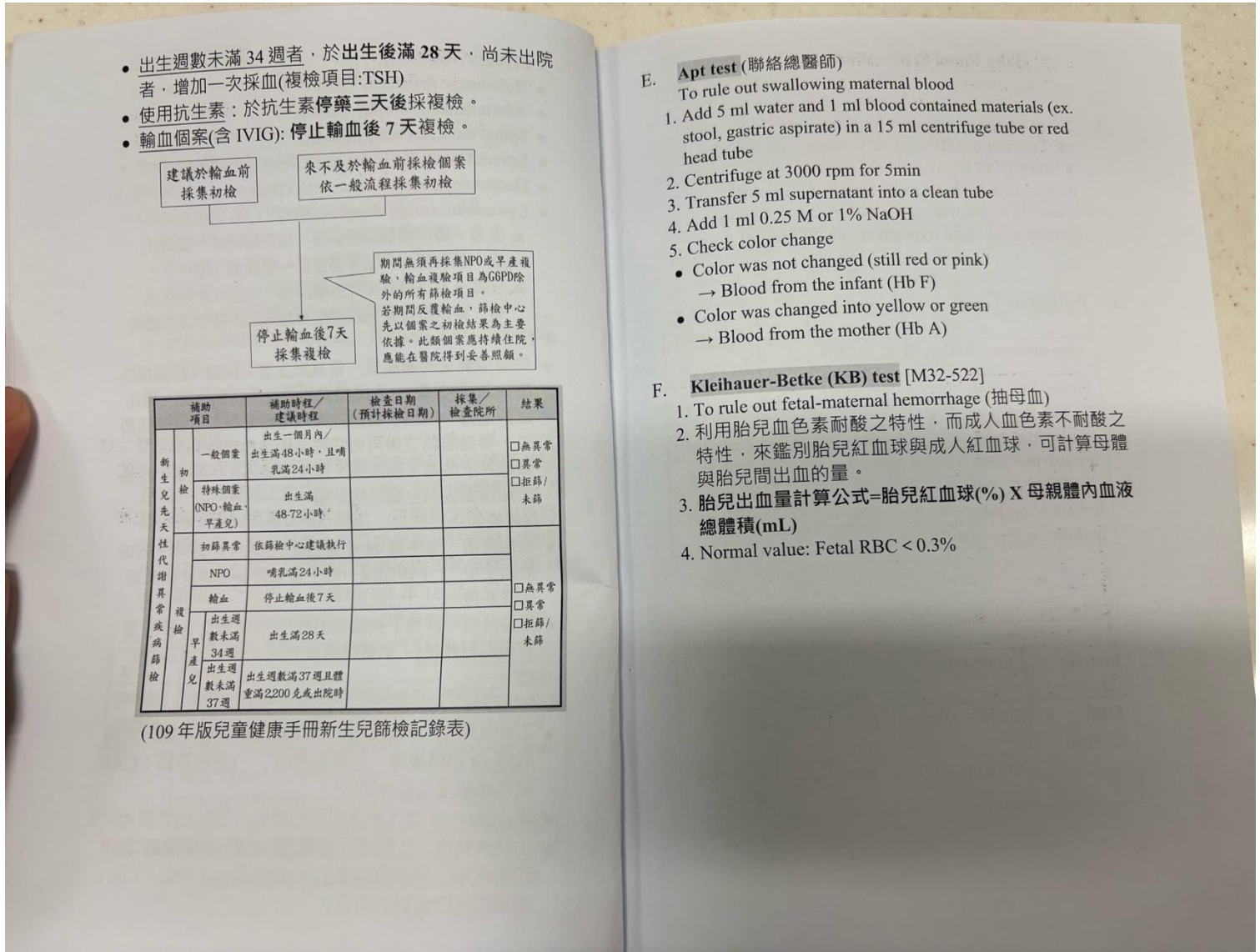
D. **新生兒篩檢**

1. 新生兒先天性代謝疾病篩檢利用簡便可靠的濾紙片採血法，在小寶寶出生之後 48 小時，經適當餵奶後，扎腳跟採少量的血滴在濾片紙上，待陰乾之後，封袋寄交篩檢中心。新生兒篩檢的目的在於及早檢測出幾種常見又可以在新生兒期加以治療的先天性代謝疾病。
2. 國健署規定之常規 21 項篩檢(108 年 10 月 1 日起):

非串聯質譜儀項目	先天性甲狀腺低能症(CHT), 半乳糖血症(GAL), 葡萄糖 6 磷酸鹽去氫酶缺乏症(G6PD), 先天性腎上腺增生症(CAH)
串聯質譜儀項目	苯酮尿症(PKU), 高胱胺酸尿症(HCU), 楓糖尿症(MSUD), 瓜胺酸血症第 I 型(CIT1), 瓜胺酸血症第 II 型(CIT2), 中鏈醯輔酶 A 去氫酶缺乏症(MCAD), 戊二酸血症第一型(GA-1), 異戊酸血症(IVA), 甲基丙二酸血症(MMA), 丙酸血症(PA), 三羥基三甲基戊二酸尿症(HMG), 全羧化酶合成酶缺乏(HCSD), 原發性肉鹼缺乏症(PCD), 極長鏈醯輔酶 A 去氫酶缺乏症(VLCAD), 肉鹼棕櫚醯基轉移酶缺乏症第 I 型(CPT1),肉鹼棕櫚醯基轉移酶缺乏症第 II 型(CPT2),戊二酸血症第 II 型(GA2)

3. 自費血片篩檢包括:
   - Biotidinase deficiency (BD)
   - Adrenoleukodystrophy (ALD)
   - Spinal muscular atropy (SMA)
   - Severe Combined Immuno-Deficiency (SCID)
   - Duchenne Muscular Dystrophy (DMD)
   - Lysosomal storage disease (LSD)：LSD 包含以下
     a. 五合一溶小體儲積症篩檢：法布瑞氏症、龐貝氏症、高雪氏症及黏多醣症第一型與第二型。
     b. 三合一溶小體儲積症先驅篩檢：黏多醣症第四 A 型、第六型及嬰兒晚發型神經元蠟樣脂褐質沉積症
4. 作法：
   - 先搓揉嬰兒的腳底板，使其充血後再採血，在腳板外圍採血(微血管)，先將寶寶的腳跟用酒精消毒，再扎以採血針，擠出少量的血液以毛細管吸取血液塗抹血片，等血陰乾之後再封袋寄至指定的篩檢中心。
   - 濾紙片上共有 6 個圈圈，至少須塗滿 6 個圈圈，每個圈圈兩面皆為全面滲透才可。
5. 採檢時間：
   - 初檢時機：出生滿 48 小時且哺乳滿 24 小時後，最晚於出生後 72 小時完成。出生後急需輸血請於**輸血前完成初檢**。
   - 複檢時機：詳見下列複檢時程(複檢時程若有多項並存可同日篩檢)。早產兒通常於滿 37 週或出院時複檢。
6. 複檢時程：
   - 未哺乳個案，仍須於出生滿 48-72 小時後初檢。於**哺乳滿 24 小時**後採「已哺乳複檢」。(複檢項目：GAL 與串聯質譜儀篩檢項目)。
   - 早產兒(< 37 週) 無論是否已哺乳，請於出生滿 48-72 小時後初檢。於新生兒**足月(滿 37 週)且體重滿 2200 克**後再採「早產兒複檢」。(複檢項目：TSH、CAH 與串聯質譜儀篩檢項目)

附件 - 嬰兒室protocol - Routine



- 出生週數未滿 34 週者，於**出生後滿 28 天**，尚未出院者，增加一次採血(複檢項目:TSH)
- 使用抗生素：於抗生素**停藥三天後**採複檢。
- 輸血個案(含 IVIG): **停止輸血後 7 天**複檢。

補助項目			補助時程／建議時程	檢查日期（預計採檢日期）	採集／檢查院所	結果
新生兒先天性代謝異常疾病篩檢	初檢	一般個案	出生一個月內／出生滿48小時，且哺乳滿24小時			□無異常 □異常 □拒篩／未篩
		特殊個案（NPO、輸血、早產兒）	出生滿48-72小時			
	複檢	初篩異常	依篩檢中心建議執行			□無異常 □異常 □拒篩／未篩
		NPO	哺乳滿24小時			
		輸血	停止輸血後7天			
		早產兒 出生週數未滿34週	出生滿28天			
		早產兒 出生週數未滿37週	出生週數滿37週且體重滿2,200克或出院時			

(109 年版兒童健康手冊新生兒篩檢記錄表)

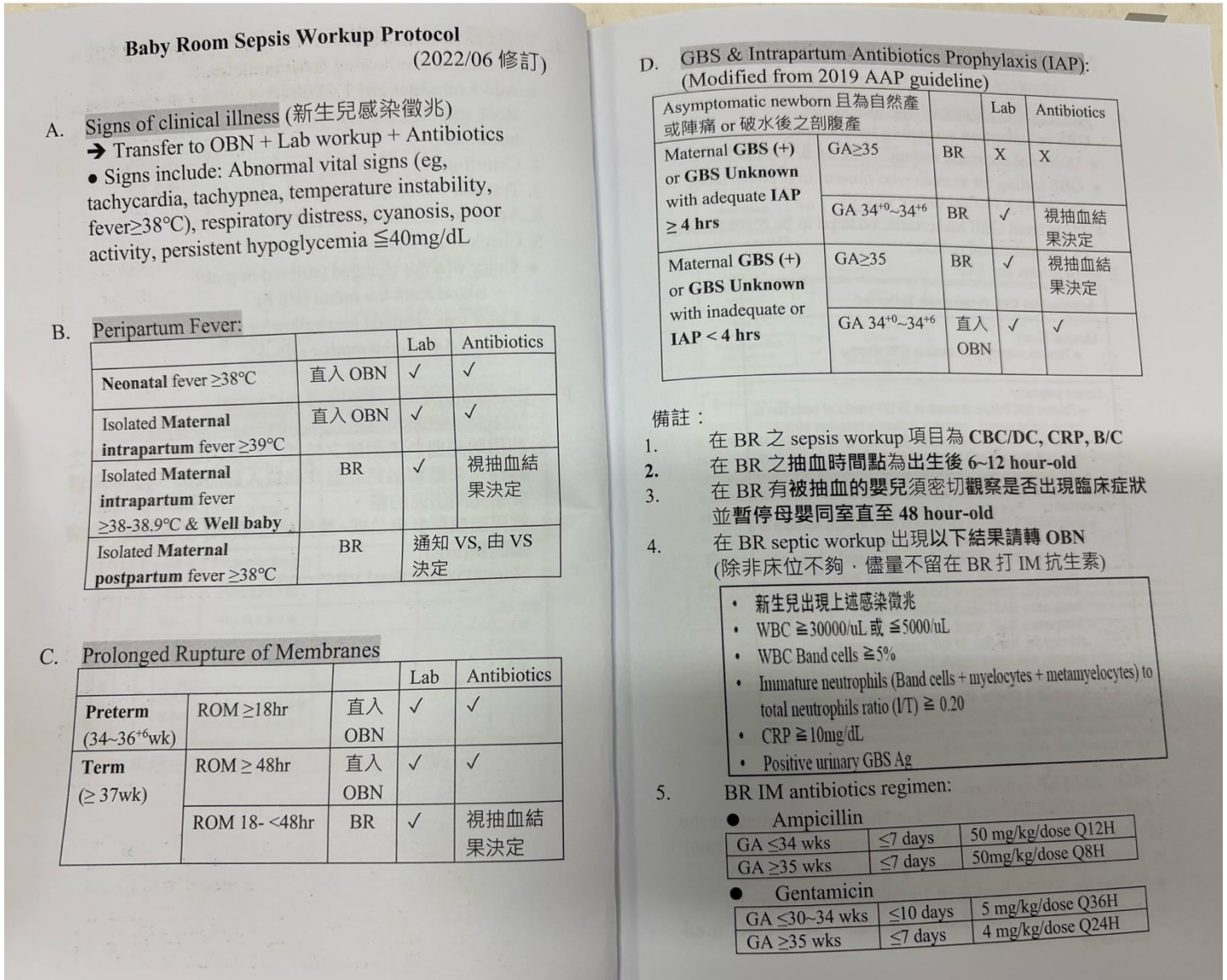
E. **Apt test** (聯絡總醫師)
To rule out swallowing maternal blood

1. Add 5 ml water and 1 ml blood contained materials (ex. stool, gastric aspirate) in a 15 ml centrifuge tube or red head tube
2. Centrifuge at 3000 rpm for 5min
3. Transfer 5 ml supernatant into a clean tube
4. Add 1 ml 0.25 M or 1% NaOH
5. Check color change
   - Color was not changed (still red or pink)
     → Blood from the infant (Hb F)
   - Color was changed into yellow or green
     → Blood from the mother (Hb A)

F. **Kleihauer-Betke (KB) test** [M32-522]

1. To rule out fetal-maternal hemorrhage (抽母血)
2. 利用胎兒血色素耐酸之特性，而成人血色素不耐酸之特性，來鑑別胎兒紅血球與成人紅血球，可計算母體與胎兒間出血的量。
3. **胎兒出血量計算公式=胎兒紅血球(%) X 母親體內血液總體積(mL)**
4. Normal value: Fetal RBC < 0.3%

附件 - 嬰兒室protocol - Sepsis Workup



Baby Room Sepsis Workup Protocol
(2022/06 修訂)

A. Signs of clinical illness (新生兒感染徵兆)
➔ Transfer to OBN + Lab workup + Antibiotics
● Signs include: Abnormal vital signs (eg, tachycardia, tachypnea, temperature instability, fever≥38°C), respiratory distress, cyanosis, poor activity, persistent hypoglycemia ≦40mg/dL

B. Peripartum Fever:

		Lab	Antibiotics
Neonatal fever ≥38°C	直入 OBN	✓	✓
Isolated **Maternal intrapartum** fever ≥39°C	直入 OBN	✓	✓
Isolated **Maternal intrapartum** fever ≥38-38.9°C & **Well baby**	BR	✓	視抽血結果決定
Isolated **Maternal postpartum** fever ≥38°C	BR	通知 VS, 由 VS 決定	

C. Prolonged Rupture of Membranes

			Lab	Antibiotics
Preterm (34~36^{+6}wk)	ROM ≥18hr	直入 OBN	✓	✓
Term (≥ 37wk)	ROM ≥ 48hr	直入 OBN	✓	✓
	ROM 18- <48hr	BR	✓	視抽血結果決定

D. GBS & Intrapartum Antibiotics Prophylaxis (IAP):
(Modified from 2019 AAP guideline)

Asymptomatic newborn 且為自然產或陣痛 or 破水後之剖腹產			Lab	Antibiotics
Maternal **GBS (+)** or **GBS Unknown** with adequate **IAP ≥ 4 hrs**	GA≥35	BR	X	X
	GA 34^{+0}~34^{+6}	BR	✓	視抽血結果決定
Maternal **GBS (+)** or **GBS Unknown** with inadequate or **IAP < 4 hrs**	GA≥35	BR	✓	視抽血結果決定
	GA 34^{+0}~34^{+6}	直入 OBN	✓	✓

備註：
1. 在 BR 之 sepsis workup 項目為 **CBC/DC, CRP, B/C**
2. 在 BR 之**抽血時間點**為**出生後 6~12 hour-old**
3. 在 BR 有**被抽血的嬰兒**須密切**觀察是否出現臨床症狀並暫停母嬰同室直至 48 hour-old**
4. 在 BR septic workup 出現**以下結果請轉 OBN**
(除非床位不夠，儘量不留在 BR 打 IM 抗生素)
   - 新生兒出現上述感染徵兆
   - WBC ≧30000/uL 或 ≦5000/uL
   - WBC Band cells ≧5%
   - Immature neutrophils (Band cells + myelocytes + metamyelocytes) to total neutrophils ratio (I/T) ≧ 0.20
   - CRP ≧10mg/dL
   - Positive urinary GBS Ag
5. BR IM antibiotics regimen:
   - Ampicillin

GA ≤34 wks	≤7 days	50 mg/kg/dose Q12H
GA ≥35 wks	≤7 days	50mg/kg/dose Q8H

   - Gentamicin

GA ≤30~34 wks	≤10 days	5 mg/kg/dose Q36H
GA ≥35 wks	≤7 days	4 mg/kg/dose Q24H

附件 - 嬰兒室protocol - GBS Workup

Management of Common Perinatal infection

Group B Streptococcus (GBS)

A. ACOG (2019) Maternal IAP guidelines

1. **GBS colonization screening indication:**
   - Universal antenatal testing at **GA 36 0/7- 37 6/7**
   - GBS testing for women who present in preterm labor and/or with PROM before GA 37.
   - If maternal GBS bacteriuria, no need to be reconfirmed by vaginal-rectal culture.

2. **Indications for IAP**

Intrapartum GBS Prophylaxis Indicated
Maternal history • Previous neonate with invasive GBS disease
Current pregnancy • Positive GBS culture obtained at 36 0/7 weeks of gestation or more during current pregnancy (unless a cesarean birth is performed before onset of labor for a woman with intact amniotic membranes) • GBS bacteriuria during any trimester of the current pregnancy
Intrapartum • Unknown GBS status at the onset of labor (culture not done or results unknown) and any of the following: ○ Birth at less than 37 0/7 weeks of gestation ○ Amniotic membrane rupture 18 hours or more ○ Intrapartum temperature 100.4°F (38.0°C) or higher* ○ Intrapartum NAAT result positive for GBS ○ Intrapartum NAAT result negative but risk factors develop (ie, less than 37 0/7 weeks of gestation, amniotic membrane rupture 18 hours or more, or maternal temperature 100.4°F (38.0°C) or higher ○ Known GBS positive status in a previous pregnancy

If intraamniotic infection is suspected, broad spectrum antibiotic that includes an agent against GBS should replace GBS prophylaxis.

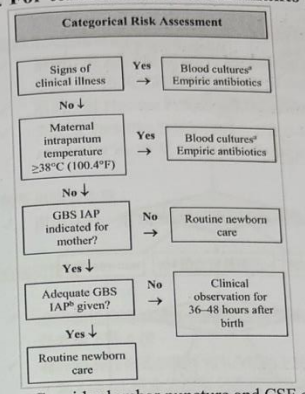
3. **Maternal IAP regimen**

Adequate GBS IAP is defined as the administration of the following medications ≥4 hours before delivery. [CDC 2010]

- Ampicillin (IV 2g load then 1g Q4H until delivery)
- Cefazolin (IV 2g load then 1g Q8H until delivery)
- Penicillin G (IV 5M U load then 2.5-3M U Q4H until delivery)

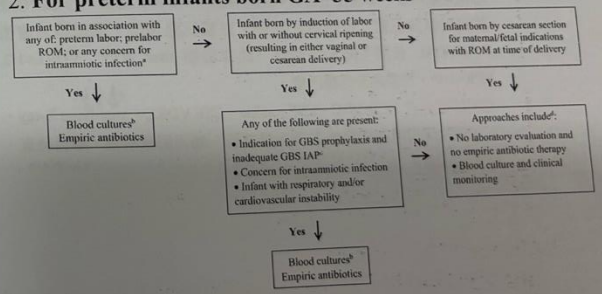
B. AAP (2019) Neonatal GBS Guidelines

1. **For term and near-term infants (GA ≥35 weeks)**



a Consider lumbar puncture and CSF culture before initiation of empiric antibiotics for infants who are at the highest risk of infection, especially those with critical illness.
b Adequate GBS IAP is defined as the administration of penicillin G, ampicillin, or cefazolin ≥4 hours before delivery.

2. **For preterm infants born GA<35 weeks**



附件 - 公費疫苗適用對象

- 幼兒沒有本國籍
  且父母均為外國籍
  且父母均未加入健保
  且父母均無居留證者

==> 以上條件都符合才不予接種

幼兒公費常規疫苗接種適用對象參照表※

107 年 7 月 26 日更新

幼兒身分別	父母國籍	加入健保情形	公費常規疫苗接種資格
幼兒有中華民國國籍	父母不論本國人或外國人	不論有無加入健保、有無居留證、有無設籍均予以接種	給予接種
幼兒無中華民國國籍	父母均為本國人	父母雙方均有加入健保	給予接種
		父母一方有加入健保	給予接種
		父母均無加入健保	給予接種
	父母一方本國人，一方為外國人	父母雙方均有加入健保	給予接種
		父母一方有加入健保	給予接種
		父母均無加入健保	給予接種
	父母均為外國人	幼兒與父母均有加入健保	給予接種
		幼兒與父母任一方有加入健保	給予接種
		幼兒與父母均無加入健保，但三方之一有居留證★	給予接種
		幼兒與父母均無加入健保，且無居留證★	不予接種

註:★:居留證含外交官員證、國際機構官員證、外國機構官員證。

※:上表所列對象係以居住在我國之幼童為考量原則，不含括短期來臺旅遊者，如遇疑問或在臺無國籍弱勢幼兒，可洽詢轄區衛生局/所。

附件 - 黃疸照光

Neonatal Hyperbilirubinemia

A. **Evaluation and management:**

1. Blood samplings: bilirubin T/D, CBC/DC, reticulocytes, U/A, U/C, Urine GBS, B/C, 懷疑 infection 要做 sepsis workup.
2. Advanced study: blood typing, Rh minor group, direct Combs' test, PB smear, G6PD activity, albumin, VDRL, HBs Ag, TORCH IgM, thyroid function
3. History: appetite, activity, breast feeding, blood typing, age of onset, hereditary disease, stool color…etc.
4. Physical exam: extent of jaundice, cephalohematoma, bruise, **signs of bilirubin encephalopathy**
5. Special considerations: IV for dehydration, antibiotics for bacterial infection, blood smear for spherocytosis, abdominal echo for adrenal hematoma….

B. **Guideline for preterm infants GA <35 weeks**[a]

	Total Serum Bilirubin (TSB) (mg/dL)	
birth weight (g)	**phototherapy**	**exchange transfusion**
< 1500	5 – 8	13 – 16
1500 – 1999	8 – 12	16 – 18
2000 – 2500	11 – 14	18 – 20

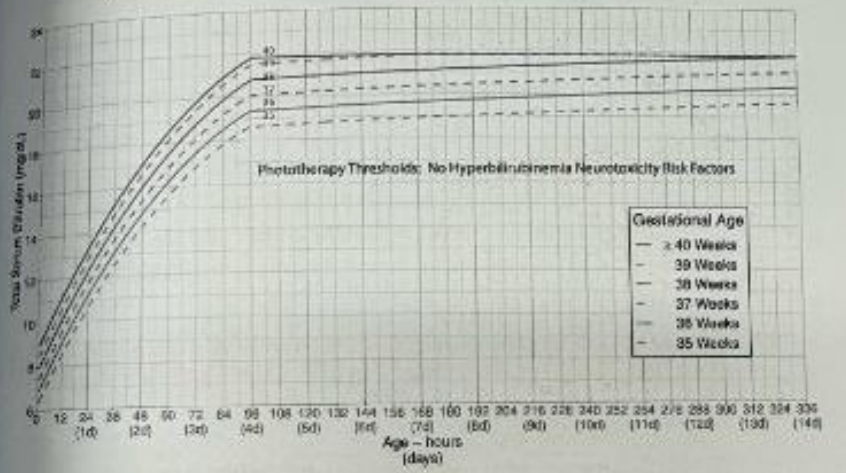
C. **Guideline for infants GA ≥35 weeks (AAP 2022)**[b]

1. **Risk Factors*** of Hyperbilirubinemia Neurotoxicity

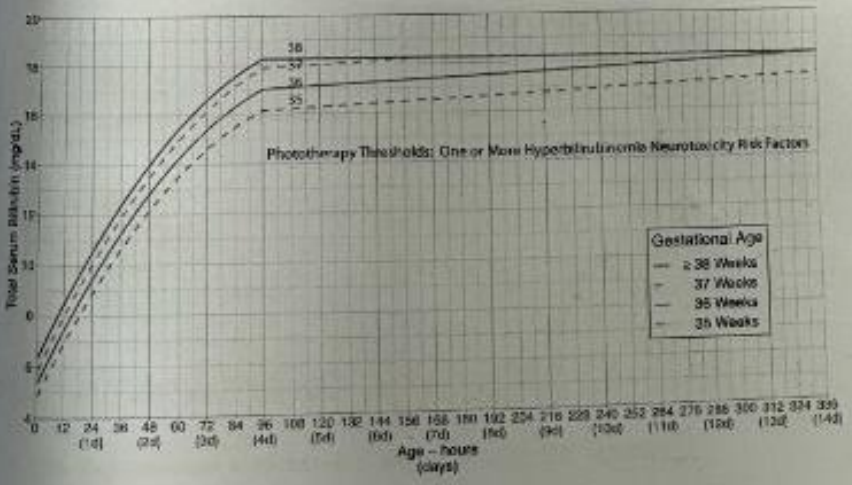
a. Gestational age <38 wk and this risk increases with the degree of prematurity
b. Albumin <3.0 g/dL
c. Isoimmune hemolytic disease (ie, positive direct antiglobulin test), G6PD deficiency, or other hemolytic conditions
d. Sepsis
e. Significant clinical instability in the previous 24 h

2. **GA ≥35 weeks Phototherapy** thresholds (照光標準):

a. **No** recognized risk factors* other than GA:



b. With **any** recognized risk factors* other than GA:



- 照光後當 TSB 降至低於照光標準 2 mg/dL 可停止照光